Documento de origen: APOYO_



Imagen 1/66: APOYO__reglas.pdf-00

Documento de origen: APOYO_ reglas.pdf

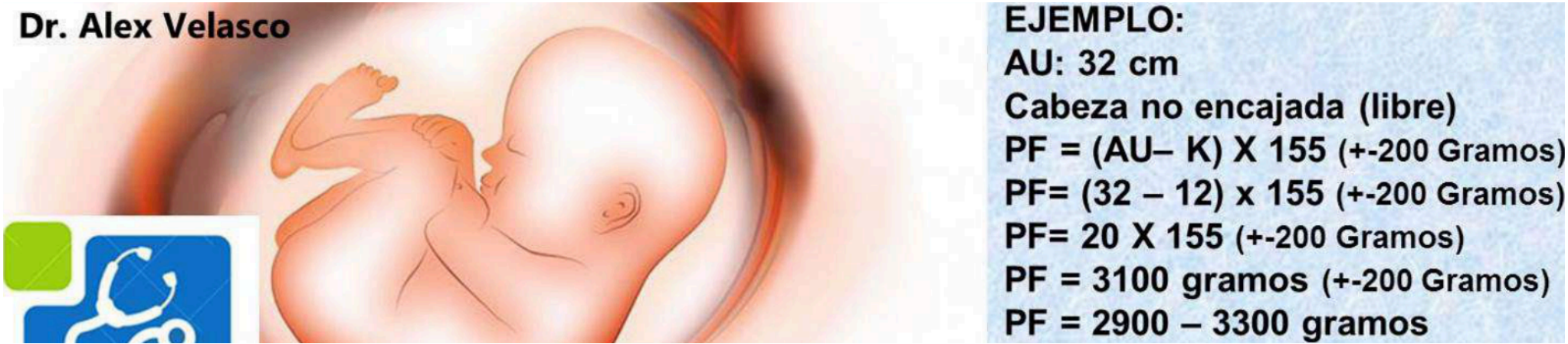


Imagen 2/66: APOYO__reglas.pdf-0002-04.png



Franz Carl Naegele

FECHA PROBABLE DE PARTO

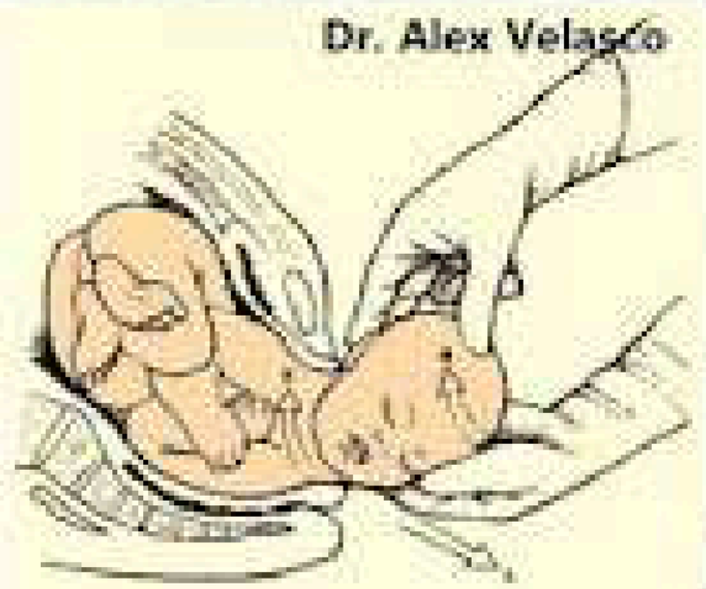
REGLA DE NAEGELE

La fórmula estima la fecha probable de parto (FPP) en función de la fecha de la última menstruación (FUM) de la mujer. A esta fecha le añadimos un año, le restamos 3 meses y le sumamos 7 días. Es decir:

FPP = FUM + 1 AÑO - 3 MESES + 7 DIAS

EJEMPLO:
FUM: 10 - 10 - 2016
FPP: (10 + 7 días) - (10 - 3 meses) - (2016 + 1 año)
FPP: 17 - 07 - 2017







Documento de origen: Definiciones y maniobras Leopold -



Imagen 4/66: Definiciones_y_maniobras_Leopold_-__Williams-O

Documento de origen: Definiciones y m



Imagen 5/66: Definiciones_y_maniobras_L

Documento de origen: Definiciones y



Imagen 6/66: Definiciones_y_maniobras_I

Documento de origen: Definiciones y maniobras Leopold - Williams-Obste

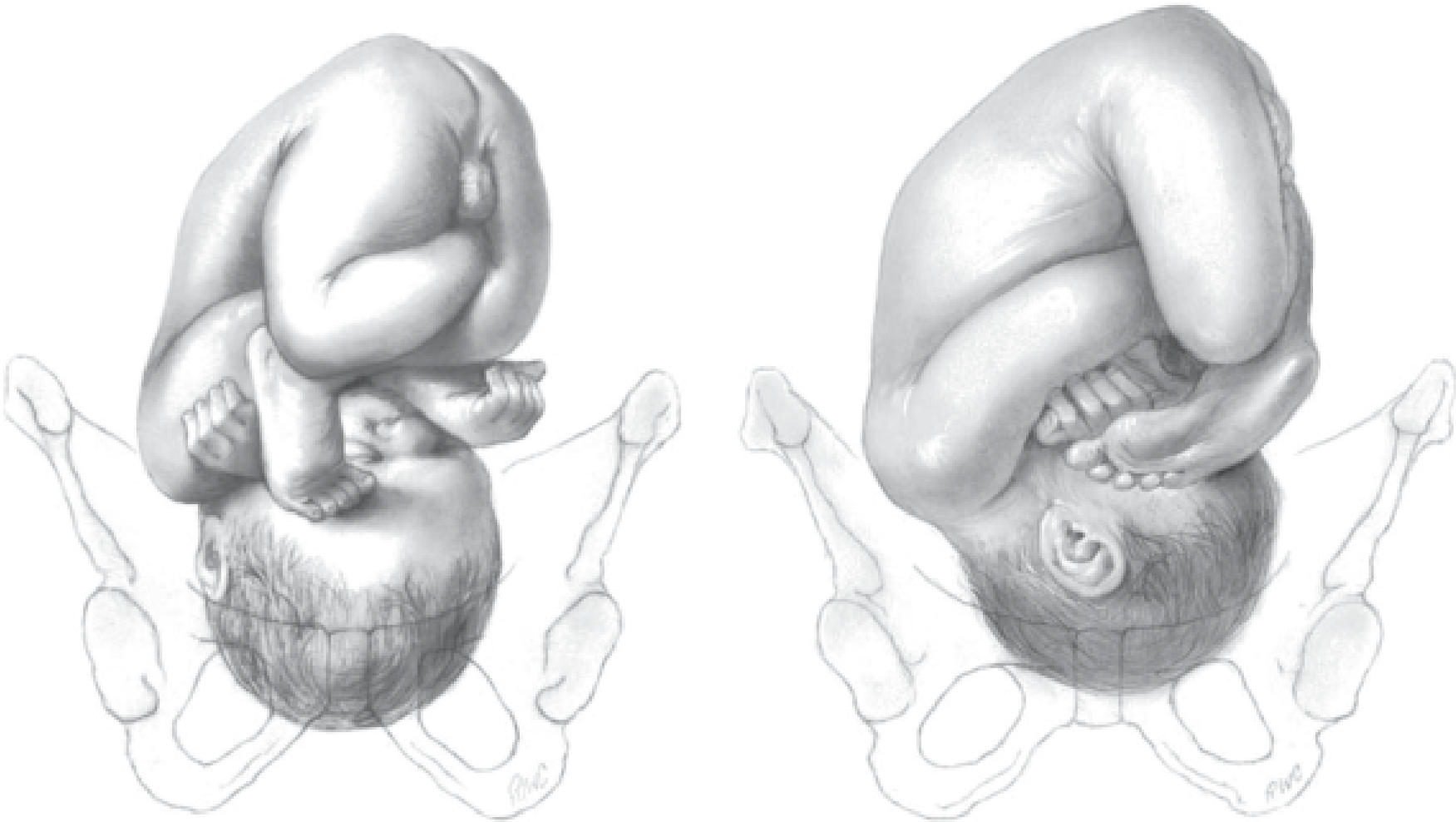


Imagen 7/66: Definiciones_y_maniobras_Leopold_-__Williams-Obstetricia.pdf-0002

Documento de

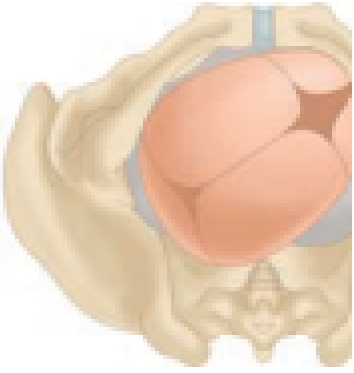


Imagen 8/66: Def

Document

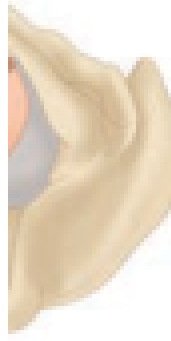


Imagen 9/6

Documento de

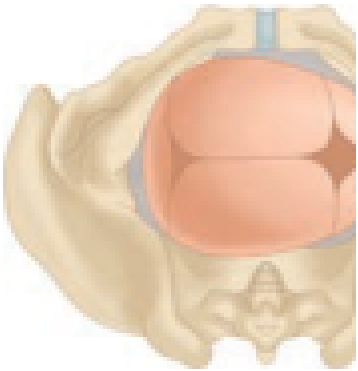


Imagen 10/66: De

Document

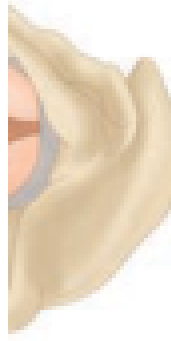


Imagen 11/

Documento de origen: Definiciones y maniob



Imagen 12/66: Definiciones_y_maniobras_Leopol

Documento de origen: Definiciones y ma



Imagen 13/66: Definiciones_y_maniobras_Le

Documento de

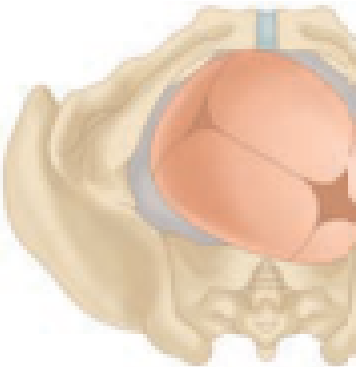


Imagen 14/66: De

Document

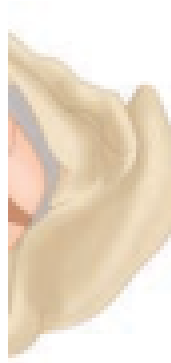


Imagen 15/

Documento de origen: Defi



Imagen 16/66: Definiciones_y

Documento de origen: Defi



Imagen 17/66: Definiciones_y_

Documento de origen: Defi



Imagen 18/66: Definiciones_y

Documento de origen: Defi

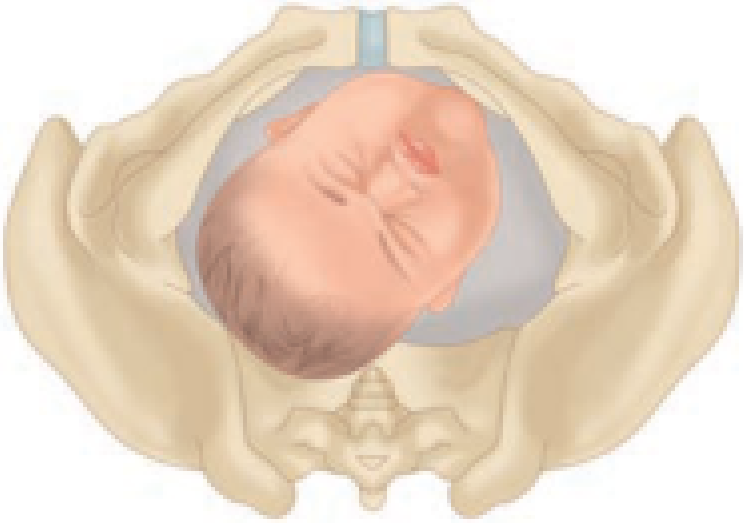


Imagen 19/66: Definiciones_y_

Documento de origen: Defi

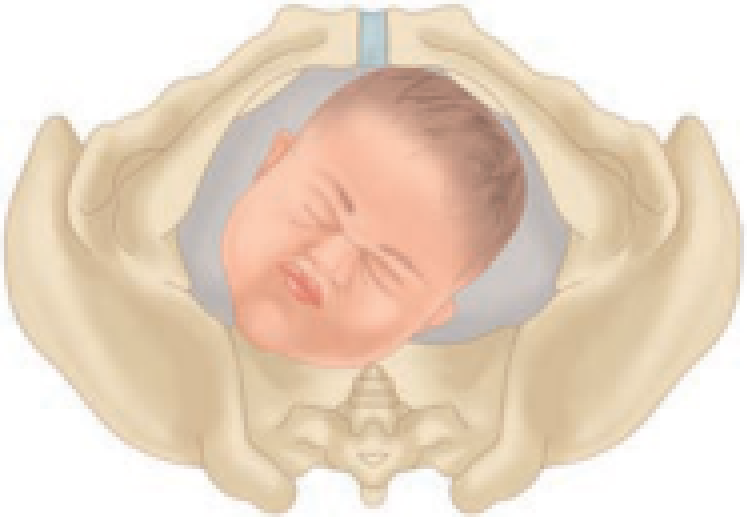


Imagen 20/66: Definiciones_y_

Documento de origen: Defi

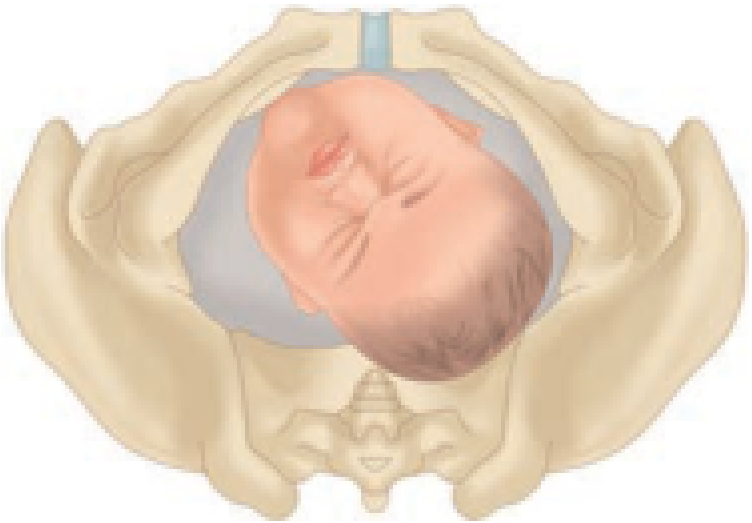


Imagen 21/66: Definiciones_y_

Documento de origen: Definiciones y maniol



Imagen 22/66: Definiciones_y_maniobras_Leopol

Documento de origen: Def

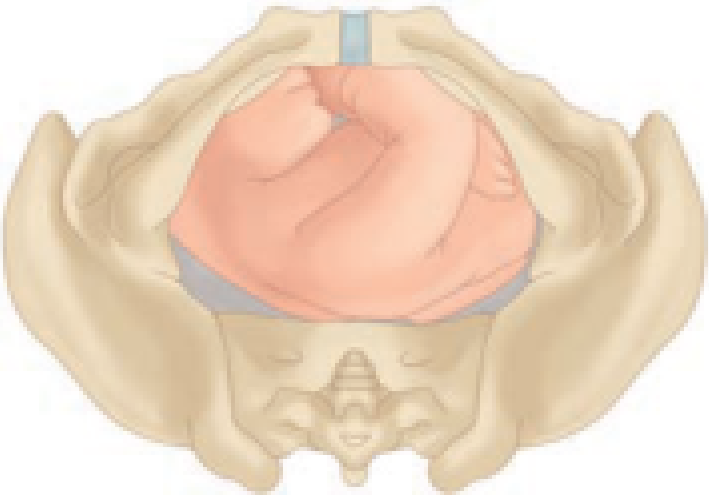


Imagen 23/66: Definiciones_y

Documento de origen: Definicio



Imagen 24/66: Definiciones_y_mar

Documento de origen: Defini



Imagen 25/66: Definiciones_y_m

Documento de origen: Definicio



Imagen 26/66: Definiciones_y_mar

Documento de origen: Definicion

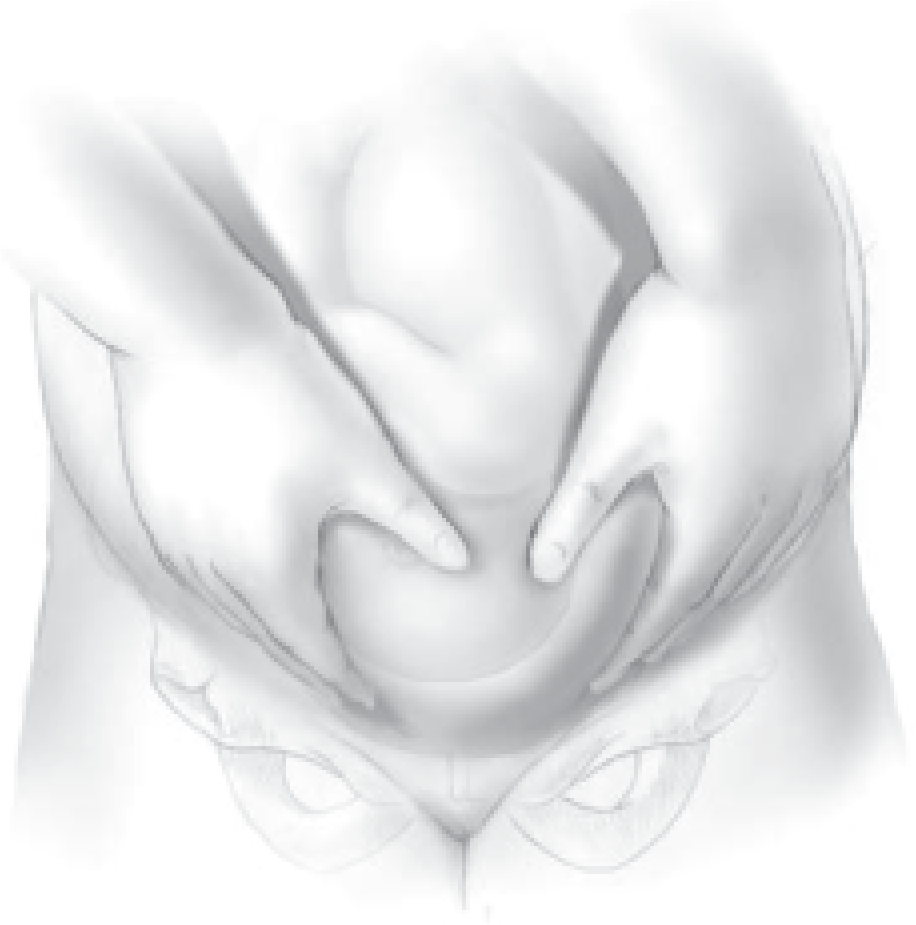


Imagen 27/66: Definiciones_y_manio

E	Un estudio para comprender mejor las expectativas de los padres acerca de los temas que se deben abordar en los programas de educación prenatal, realizado a 181 padres, refiere que 86 padres prefirieron recibir capacitación en sesiones en vivo, en comparación con recibir capacitación en línea. Los temas que fueron categorizados como más importantes para los padres fueron: trabajo de parto y seguridad del recién nacido, seguidos de lactancia y apego.	**2+** **NICE** *Kovala S, 2016*
R	Se recomienda reforzar y priorizar los contenidos de los temas como trabajo de parto, seguridad del recién nacido, lactancia y apego en los programas de educación prenatal.	**B** **NICE** *Kovala S, 2016*
E	Un estudio en 604 mujeres embarazadas en China, para evaluar la participación, implementación, y los efectos de un programa de educación prenatal otorgado por diferentes hospitales, para mejorar la atención prenatal, muestra que las mujeres que aceptaron participar en un programa de educación prenatal (175), tuvieron una mayor asistencia a las evaluaciones prenatales (57.9 vs. 48.3 %), y una mayor probabilidad de recuperarse bien y muy bien (80 vs. 73.7 %) de su último parto, comparadas con aquellas mujeres que no participaron en las sesiones de educación prenatal ($P < 0.05$).	**2+** **NICE** *Shi Y, 2015*
R	Se recomienda integrar a toda mujer embarazada a programas de educación prenatal, para mejorar la salud de la madre y el producto, por medio de sesiones estructuradas y en las que de preferencia participe también la pareja. Las mujeres que participan logran una mejor recuperación después del parto.	**B** **NICE** *Shi Y, 2015*
E	Una revisión sistemática cuyo objetivo fue estimar el efecto de los cuidados prenatales en grupo en los desenlaces perinatales comparado con el cuidado prenatal tradicional individual, muestra que la participación en los cuidados prenatales grupales no se asocia con menores tasas de nacimientos pretérmino, menor hospitalización en Unidades de Cuidados Intensivos neonatales, o diferencias en el inicio de la lactancia materna.	**1++** **NICE** *Carter E, 2017*
R	No hay evidencia al momento de que los cuidados prenatales en grupo sean superiores al cuidado prenatal individual, por lo tanto, no se recomienda el grupal sobre el individual; debe existir común acuerdo entre personal médico y la paciente.	**1++** **NICE** *Carter E, 2017*

	34% para el grupo de bajo peso para la edad al nacer en comparación con el grupo de control.	
R	Es recomendable orientar a la persona embarazada para llevar una dieta equilibrada proteico-energética, debido a que puede ayudar a reducir la prevalencia de bajo peso al nacer, y de peso bajo para edad gestacional.	**B** **NICE** *Imdad A,2012*
E	Los componentes clave de una alimentación saludable durante el embarazo incluyen: Consumo de una variedad de alimentos principalmente integrales y sin procesar en cantidades adecuadas para permitir un aumento de peso gestacional adecuado, pero no excesivo. • Aumento de peso gestacional adecuado • Suplementación adecuada de vitaminas y minerales. • Evitar consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias nocivas.	**4** **NICE** *Kaiser L, 2010*
	Consumo de cafeína	
E	En la persona embarazada el metabolismo de la cafeína es más lento, con una semivida de eliminación de 1.5 a 3.5 veces mayor. Se ha detectado en el líquido amniótico, el cordón umbilical, la orina y el plasma de los fetos, lo que sugiere que cruza fácilmente a través de la placenta. La inmadurez del hígado del feto produce un bajo nivel de enzimas necesarias para el metabolismo de la cafeína, y deja a las personas recién nacidas en riesgo de resultados adversos, incluyendo bajo peso al nacer.	**2+** **NICE** *Carter E, 2015*
E	Un estudio de cohorte prospectivo, cuyo objetivo fue evaluar si un mayor consumo de cafeína aumentaba el riesgo de aborto en el embarazo, muestra que una ingesta mayor de cafeína en el embarazo se asocia con un aumento en el riesgo de aborto (HR 1.42, IC 95%, 0.93 a 2.15), para una ingesta de menos de 200 mg/día, y un HR de 2.23 para una ingesta de 200 o más mg/día, respectivamente.	**2++** **GRADE** *Weng X, 2008*
R	Se recomienda ingesta de cafeína menor de 200 mg/día para disminuir el riesgo de aborto espontáneo.	**B** **NICE** *Weng X, 2008*

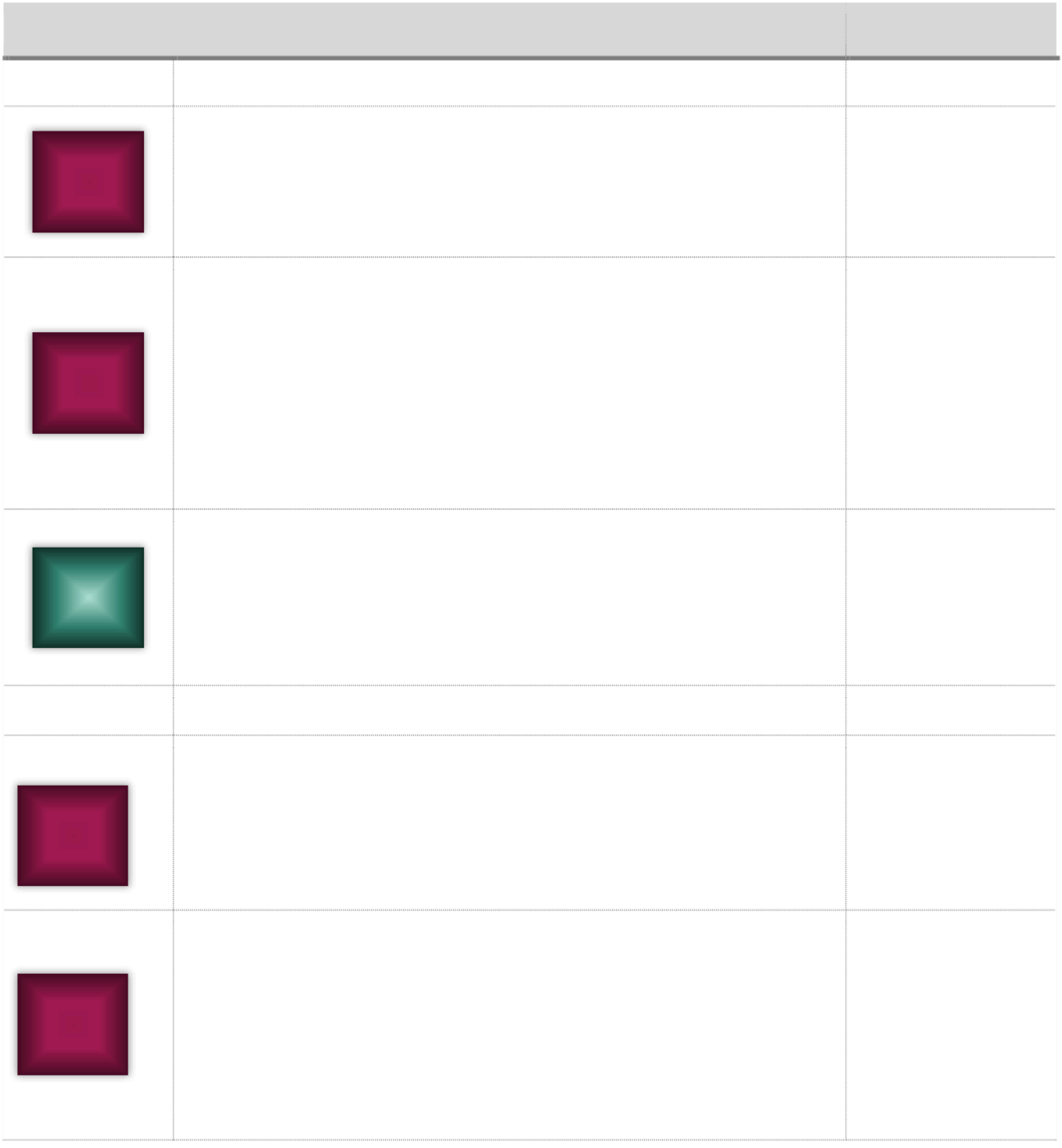
	• De 0 a 4 kg en mujeres con obesidad grado 2. • De 0 a menos de 6 kg en mujeres con obesidad grado 3 (ver cuadro 3)	
	Se recomienda registrar el IMC previo al embarazo y, de acuerdo con esto, establecer metas de ganancia de peso gestacional por trimestre.	**A** **NICE** *LifeCycle Project, 2019*
	Se recomienda que toda mujer embarazada sea valorada por el personal de nutrición al menos en una ocasión, con el fin de otorgar consejería sobre medidas higiénico-dietéticas.	**PBP**
	Ácidos grasos poliinsaturados	
	Una revisión sistemática de 70 ensayos controlados aleatorizados (ECA); con 19,927 pacientes, cuyo objetivo fue evaluar los efectos de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPICL) omega 3, como suplementos o como adiciones dietéticas, durante el embarazo, encontró que la ingesta de 500 mg a 1000 mg por día, a partir de las 12 semanas de embarazo, disminuye la incidencia de: • Parto prematuro en un 11% (antes de las 37 semanas) con un RR de 0.89 (0.81 a 0.97). • Parto muy prematuro un 42% (antes de las 34 semanas) con un RR 0.58 (0.44 a 0.77.	**1++** **NICE** *Middleton P, 2018*
	Se sugiere consumir de 500 mg a 1000 mg por día de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPICL) omega 3, a partir de las 12 semanas para reducir el riesgo de parto pretérmino y parto prematuro.	**A** **NICE** *Middleton P, 2018*

	El tabaquismo pasivo no se asoció con el aborto espontáneo RR 1,11 (0,95 a 1,31)	
E	En una revisión sistemática con metaanálisis que incluyó 1,713 artículos y en el metaanálisis 142 artículos, cuyo objetivo fue evaluar la relación entre el tabaquismo y la muerte perinatal, se encontró que el tabaquismo activo se asocia a: • Muerte fetal RR 1,46 (1,38 a 1,54) • Muerte neonatal RR 1,22 (1,14 a 1,30) • Muerte perinatal RR 1,33 (1. 25, 1,4)	**1++** **NICE** *Pineles B, 2016*
E	En una revisión sistemática que incluyo 284 resúmenes, y 16 artículos, cuyo objetivo fue buscar asociaciones entre el tabaquismo materno durante el embarazo y las mediciones ecográficas, muestra que el tabaquismo activo se asocia con un menor peso fetal con un RR 0,18 (0,11 a 0,24).	**1++** **NICE** *Abraham M, 2017*
E	En una revisión sistemática que incluyó 190 ensayos controlados aleatorizados, cuyo objetivo fue evaluar las principales estrategias de intervención para el cese de tabaquismo, encontró que la consejería anti-tabaco: • redujo la dependencia de nicotina con un RR 1,44 (1,19 a 1,73) • Intervenciones menos intensivas reducen la dependencia de nicotina con un RR de 1,25 (1,07 a 1,47). • Prolongó la abstinencia de cero a cinco meses después del parto RR 1,59 (1,26 a 2,01) y de 12 a 17 meses RR medio 2,20 (1,23 a 3,96. Las pacientes que recibieron intervenciones psicosociales tuvieron una reducción del 17% en neonatos nacidos con bajo peso al nacer, un peso al nacer medio significativamente mayor (55,60 g) y una reducción del 22% en los ingresos a la unidad de cuidados intensivos neonatales.	**1++** **NICE** *Chamberlain C, 2017*

Documento de origen: GPC Atención y cuidados multidisciplinarios en el embarazo.pdf

Rc	Se recomienda aplicar la vacuna triple viral (SRP-sarampión, rubeola y parotiditis)) a todos los niños, tanto hombres como mujeres, entre el año y los 2 años de edad. Se sugiere repetir la dosis en los niños de 4 a 5 años de edad, y nuevamente antes de la pubertad.	**B** **NICE** *Mackin D, 2021*
✓	No se sugiere aplicar la vacuna contra Rubeola durante el embarazo, aunque la evidencia muestra que el riesgo de daño es bajo, debido a la posibilidad teratogénica de utilizar vacunas con virus vivos atenuados.	**PBP**
	Vacunas que confieren inmunidad pasiva al neonato	
	Tétanos	
E	Diversos estudios observacionales durante los años 60, demostraron que el uso de dos o más dosis de toxoide tetánico durante el embarazo podían prevenir el tétanos neonatal. Un ensayo clínico aleatorizad doble ciego, con 1,618 mujeres realizado en Colombia, con un seguimiento a 5 años, mostró que en las mujeres que recibieron 2 a 3 dosis del toxoide tetánico, no se reportaron muertes neonatales debido al tétanos, comparado con 7.8 defunciones por 100 nacimientos entre los bebés de madres no vacunadas. Estudios subsecuentes muestran que la vacuna en mujeres embarazadas reduce la mortalidad neonatal por tétanos en un 94%.	**2++** **NICE** *Mackin D, 2021*
Rc	Se recomienda vacunar a todo niño, mujer embarazada, y mujer en edad fértil, con toxoide tetánico.	**B** **NICE** *Mackin D, 2021*
	Bordetella pertussis	
E	En el periodo entre 1926 y 1930, hubo 36,103 muertes por pertussis en los Estados Unidos, con un número desproporcionado de muertes entre niños pequeños. En 1976, con el uso generalizado de la vacuna, se observó una disminución dramática en la incidencia de la enfermedad disminuyendo de 250,000 a 1,010. De acuerdo con múltiples estudios observacionales, la vacuna es segura en el embarazo, sin mostrar incrementos en los desenlaces adversos perinatales.	**2++** **NICE** *Mackin D, 2021*
Rc	Se recomienda vacunar con DTaP entre las semanas 16 y 32 de la gestación, a las mujeres embarazadas que no se hubieran vacunado previamente, para conferir inmunidad pasiva a los neonatos.	**B** **NICE** *Mackin D, 2021*

Imagen 32/66: GPC_Atención_y_cuidados_multidisciplinarios_en_el_embarazo.pdf-0027-00.png



Documento de origen: GPC Atención y cuidados multidisciplinarios en el embarazo.pdf

E	No se ha identificado con claridad si se debe realizar un tamizaje universal o selectivo para el diagnóstico de Diabetes Gestacional, ya que no existen pruebas basadas en ensayos de muy buena calidad que identifiquen el mejor enfoque para mejorar desenlaces materno-fetales.	**1++** **NICE** *Farrar D, 2017*
E	Debido al aumento de obesidad y edad avanzada al momento del embarazo, la Diabetes Gestacional ha mostrado en años recientes una mayor incidencia.	**4** **NICE** *ADA, 2020*
R	Es recomendable evaluar el riesgo de diabetes gestacional en toda mujer embarazada desde la primera consulta prenatal. (Ver Anexo 5.3 Cuadro 5)	**B** **NICE** *ADA, 2020*
Rc	Se sugiere realizar tamizaje universal para Diabetes a todas las mujeres con riesgo bajo o moderado entre las 24-28 semanas de gestación.	**A** **NICE** *ADA, 2020*
E	De acuerdo a un estudio de cohorte prospectivo, los riesgos de padecer Diabetes durante el embarazo son: • Aborto espontáneo • Anomalías fetales • Preeclampsia • Macrosomía • Hipoglicemia neonatal • Hiperbilirrubinemia • Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido • Muerte fetal Además, la diabetes incrementa el riesgo de obesidad, hipertensión, y aparición de diabetes tipo 2 en un periodo posterior de la vida.	**2++** **NICE** *Holmes VA, 2011*
E	La ADA, de acuerdo a sus estándares de tratamiento publicados en 2015, mantiene la alternativa de utilizar los criterios de IADPSG (International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups) o de CC (Carpenter & Coustan), pero, de acuerdo a la nueva evidencia que ha ido apareciendo, recomienda utilizar los criterios de IADPSG ya que esto implica una disminución en la morbilidad materno fetal.	**4** **NICE** *Durán Rodríguez Hervada A, 2015*

Imagen 34/66: GPC_Atención_y_cuidados_multidisciplinarios_en_el_embarazo.pdf-0029-00.png

E	Se realizó un ensayo clínico aleatorizado para comparar tamizaje de 1 paso (carga de 75 gramos en ayuno) vs tamizaje de 2 pasos (medición de glucemia después de carga 50 gramos sin ayuno, seguida de curva de tolerancia a la glucosa con carga de 100 gramos en ayuno), con 23,792 mujeres embarazadas en donde se diagnosticó diabetes gestacional en 16.5% en tamizaje 1 paso, y 8.5% en tamizaje de 2 pasos con RR 1.94 (1.79 a 2.11). sin embargo, no se demostró diferencia significativa entre los grupos en cuanto a complicaciones materno y neonatales.	**1++** **NICE** *Hillier TA, 2021*
R	Se sugiere utilizar los criterios IADPSG: **Estrategia de un solo paso**, con sobrecarga oral de glucosa de 75 g, si al menos **uno** de los valores es: • ≥ 92 mg/dl en ayuno • ≥ 180 mg/dl a la hora de la toma • ≥ 153 mg/dl a las 2 horas de la toma se considera diagnóstico de ***Diabetes Gestacional***, ya que, aunque incrementan la prevalencia de la enfermedad, reducen la aparición de complicaciones, reducen costos de atención, y reducen la morbilidad materno fetal.	**D** **NICE** *Durán Rodríguez Hervada A, 2015*
E	La gran mayoría de guías en los Estados Unidos favorecen el **abordaje de dos pasos** en el tamizaje de Diabetes Gestacional, primero administrando: 50 g sin ayuno en la prueba de tolerancia a la glucosa oral, en las semanas 24 a 28, seguida de una carga de 100 g de glucosa en ayuno, en las mujeres que tuvieron resultados positivos durante el tamizaje previo. Se considera diagnóstico de ***Diabetes Gestacional*** si se encuentran valores de: • 95 mg/dl en ayuno • 180 mg/dl a la hora de la toma • 155 mg/dl a las 2 horas de la toma • 140 mg/dl a las 3 horas de la toma Sin embargo, también puede utilizarse el abordaje sugerido por la OMS con una carga de 75 g a las 2 h de ayuno en la prueba de tolerancia a la glucosa oral, con un límite menor para el diagnóstico de diabetes gestacional comparado con el abordaje de dos pasos.	**4** **NICE** *Mack L, 2017*
E	Un estudio prospectivo en 999 mujeres embarazadas, a quienes se les realizó glucosa plasmática sin ayuno en la primera visita de control prenatal, que consistió en dar una carga oral de glucosa de 50 g, seguida de una determinación de glucosa en plasma pasando una hora, y en quienes obtuvieran un resultado mayor de 130 mg/dl, se les realizó una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 3 h, encontró que el 13% de las pacientes diagnosticadas con diabetes	**2++** **NICE** *ADA, 2016*

	• Reducción del 14% en las muertes fetales o neonatales RR 0,86 (0,76 a 0,98); NNT 243. Reducción del 10% peso bajo al nacer RR 0,90 (0,83 a 0,98).	
Rc	Se recomienda administrar ácido acetilsalicílico a dosis 150 mg / día desde las 12 semanas de gestación hasta la semana 36, en mujeres que presentan al menos un factor de riesgo alto o al menos 2 factores de riesgo moderado de preeclampsia.	**A** **NICE** *Duley L, 2007*
E	En un estudio cohorte prospectiva donde se incluyeron 57,458 pacientes, se realizó tamizaje para determinar riesgo de preeclampsia en primer trimestre incluyendo índice medio de pulsatilidad de las arterias uterinas, la presión arterial media (PAM) y marcadores bioquímicos [la proteína A plasmática asociada al embarazo (PAPP-A) y factor de crecimiento placentario (PLGF). El estudio detectó el 96% de los casos de preeclampsia antes de las 34 semanas y el 54% de todos los casos de EP con una tasa fija de falsos positivos del 10%.	**2+** **NICE** *Akolekar R, 2013*
R	Se recomienda que en las pacientes que sean captadas entre la semana 11 y 13.6, que cuentan con riesgo alto o moderado para preeclampsia, se realice tamizaje tomando en cuenta factores de riesgo, marcadores bioquímicos y medición de arterias uterinas.	**2+** **NICE** *Akolekar R, 2013*
E	El ensayo ASPRE, corte prospectiva y multicéntrico donde se incluyeron 26,941 pacientes cuyos objetivos fueron: • Determinar el rendimiento del tamizaje de la preeclampsia (EP) temprana y tardía. • Determinar la eficacia de tratamiento con aspirina para la prevención de la preeclampsia. Donde se encontró que: La administración de ácido acetilsalicílico a dosis de 150 mg por día desde las 11 semanas de gestación hasta las 36 semanas de gestación, resultó en una reducción del 62% en la incidencia de EP prematura (NTT de 303), pero no tuvo un efecto significativo sobre la incidencia de EP a término.	**2+** **NICE** *Rolnik D, 2017*
R	Se recomienda administración de aspirina la administración de 150 mg por día de ácido acetilsalicílico en las pacientes con riesgo alto de preeclampsia, desde las 11 semanas de gestación hasta las 36 semanas de gestación.	**B** **NICE** *Rolnik D, 2017*
✓	De no contar con ultrasonido Doppler y marcadores bioquímicos, tomar en consideración los factores de riesgo moderado y alto para el uso de ácido acetil salicílico profiláctico. (considere el número necesario a tratar para prevenir una preeclampsia).	**PBP**

Rc	Se recomienda realizar tamizaje con prueba rápida en el primero y tercer trimestre del embarazo, con la finalidad de detectar a todas aquellas pacientes portadoras del virus de inmunodeficiencia humana, e iniciar las acciones correspondientes. Si la prueba resulta positiva, se recomienda realizar inmunoensayo enzimático.	**A** **NICE** *Selph S, 2012*
R	Se sugiere repetir el estudio para VIH en el segundo trimestre si la mujer mantiene prácticas de riesgo, especialmente si su pareja está infectada por el VIH.	**A** **NICE** *Selph S, 2012*

	satisfechas con los grupos de visitas reducidas y percibieron el lapso entre cada consulta como demasiado largo.	
E	En Estados Unidos, los programas de control prenatal para las mujeres nulíparas consisten en 1 visita cada 4 semanas hasta la semana 28 de gestación, una visita cada 2 semanas de la semana 28 a la 36 de gestación, y 1 visita cada semana hasta el parto. Por lo tanto, una mujer que acude desde la semana 6 de gestación hasta la semana 41 de forma regular, habrá recibido un total de 16 atenciones.	***4*** ***NICE*** *Lockwood C, 2021*
E	La guía de cuidados prenatales de la OMS del año 2016, derivado de una revisión sistemática del año 2015, sugiere un esquema de 8 visitas para todas las mujeres, independientemente del número de embarazos. Sugieren 1 visita en el primer trimestre, 2 visitas en el segundo trimestre y 5 visitas en el tercer trimestre. La revisión sistemática muestra un incremento del 15% en las muertes perinatales en mujeres con embarazo de bajo riesgo de países con ingresos medios y bajos con un programa de visitas prenatales reducido. Evidencia reciente indica que una mayor frecuencia de visitas de control prenatal por parte de mujeres y adolescentes se asocia con una reducción de parto pretérmino, esto se da por el incremento en la oportunidad para detectar y manejar complicaciones potenciales. 8 o más consultas prenatales pueden reducir la muerte perinatal en alrededor de 8 por cada 1000 nacimientos si se compara con 4 visitas.	***1+*** ***NICE*** *Guía OMS, 2016*
E	El National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) sugiere un número reducido de visitas; 10 visitas en mujeres nulíparas y 7 visitas en mujeres multíparas. Cada visita debe tener un contenido y objetivo específico. Este abordaje toma en cuenta la falta de tiempo de las pacientes y la falta de evidencia sólida derivada de ensayos clínicos que sugieran mejores desenlaces con un número mayor de visitas de control prenatal.	***4*** ***NICE*** *Guía NICE 2016*
Rc	Se recomienda continuar el esquema de atención prenatal de 10-12 visitas en mujeres de países de bajos ingresos, para reducir la mortalidad perinatal y cumplir las expectativas de atención de las pacientes.	***A*** ***NICE*** *Dowswell T, 2015*
	Duración de consulta prenatal	

E	La OMS, de acuerdo con un consenso de expertos, establece que la duración de la primera visita de control prenatal debe realizarse preferentemente antes de la semana 12 de embarazo; la primera visita debe durar al menos entre 30 a 40 minutos y para las visitas subsecuentes establece un tiempo de 20 minutos. Las pacientes que inicien de forma tardía el control prenatal (después de la semana 32), se les deberán realizar todas las actividades de las citas previas más las que correspondan.	**4** **NICE** *Guía Chile 2013*
E	La Guía NICE, de acuerdo con un consenso de expertos, establece que la primera cita de control prenatal debe durar al menos el equivalente de dos citas de control prenatal.	**D** **NICE** *Guía Chile 2013*
R	Se recomienda que el primer control prenatal se lleve a cabo en el primer trimestre, antes de la semana 12 de embarazo, y que la primera visita de control prenatal dure al menos 30 a 40 minutos. Para las visitas subsecuentes se recomienda una duración de al menos 20 minutos.	**D** **NICE** *Guía Chile 2013*
E	Los elementos estándar de los cuidados prenatales deben incluir: • historia clínica y exploración física, en la visita inicial; • el peso de la madre y la presión arterial en cada visita, • auscultar el latido cardiaco fetal a partir de la semana 10 con un monitor Doppler o después de la semana 20 con un fetoscopio, • medición de altura uterina después de la semana 20 • presentación fetal en la semana 36.	**4** **NICE** *Zolotor A, 2014*
R	Se recomienda que las visitas de control prenatal tengan un contenido bien estructurado, claro, que permita evaluaciones integrales, que incluya exploración física, pruebas de laboratorio y que esté dirigido a la identificación de factores de riesgo y la disminución de complicaciones.	**D** **NICE** *Zolotor A, 2014*
R	En la primera visita de control prenatal, se debe investigar el historial familiar, obstétrico, quirúrgico y psicosocial, para llevar a cabo la correcta evaluación e identificación de riesgos.	**D** **NICE** *Zolotor A, 2014*
E	Los elementos que debe incluir el expediente son: • Información personal y demográfica • Antecedentes gineco-obstétricos • Antecedentes médicos, que incluyan alergias, uso de medicamentos e inmunizaciones, evaluación del riesgo para enfermedades hereditarias, uso de sustancias, historial de infecciones, riesgos de exposición a teratógenos	**4** **NICE** *Lockwood C, 2021*

	de la última regla. En caso de periodos irregulares o cuando la fecundación tiene lugar antes o después del día 14, la fecha puede variar.	
E	Esta revisión narrativa concluye que existen un gran número de factores que pueden influenciar significativamente la duración de un embarazo, como raza, estatura, variaciones en el ciclo menstrual, la temporalidad de la ovulación, paridad y el peso materno.	***4*** ***NICE*** *Lawson GW, 2020*
E	Un estudio para evaluar el porcentaje de nacimientos pretérmino en los Estados Unidos, utilizando dos métodos diferentes para el cálculo de la edad gestacional y para determinar qué método se correlaciona mejor con las morbilidades asociadas con los nacimientos pretérmino, muestra que la tasa de nacimientos pretérmino fue de 9.7% cuando se utilizó una estimación obstétrica (ultrasonido y más parámetros) para calcular la edad gestacional, comparado con 11.5% cuando se utilizó el último periodo menstrual para calcular edad gestacional.	***2++*** ***NICE*** *Duryea E, 2015*
E	La medición por ultrasonido del embrión en el primer trimestre (hasta las 13 semanas de gestación) es el método más preciso para establecer o confirmar la edad gestacional.	***1+*** ***NICE*** *Comité de Práctica Obstétrica, 2017*
E	En un estudio, al 40% de las mujeres que fueron aleatorizadas para que se les hiciera ultrasonido en el primer trimestre, se les tuvo que ajustar la fecha probable de parto por una discrepancia de más de 5 días entre los datos del ultrasonido y su fecha de última menstruación. Las fechas de parto estimadas solo se ajustaron en un 10% de mujeres en el grupo control que se les hizo ultrasonido en el segundo trimestre, lo que sugiere que una evaluación por ultrasonido en el primer trimestre mejora la precisión de la fecha probable de parto, aunque se conozca el primer día de la fecha de última menstruación.	***1+*** ***NICE*** *Comité de Práctica Obstétrica, 2017*
R	Se recomienda utilizar la Regla de Naegele para calcular la fecha probable de parto cuando no se tengan disponibles otros recursos más precisos como el ultrasonido.	***B*** ***NICE*** *Duryea E, 2015*
✓	Se debe utilizar siempre el primer día de la última menstruación para el cálculo de la fecha probable de parto en la Regla de Naegele, siempre y cuando la fecha de última menstruación sea confiable.	***PBP***

E	Una revisión sistemática con metaanálisis para evaluar la precisión diagnóstica del ultrasonido transabdominal y transvaginal en dos dimensiones para la detección de anormalidades fetales congénitas antes de 14 semanas de gestación, muestra que el porcentaje de detección en los grupos de alto riesgo es de 60%, y en los grupos de bajo riesgo es de 32%, lo que muestra el potencial para detectar anormalidades estructurales en una gran proporción de fetos. Se encontraron anomalías de diversos tipos en 1.8 de 100 fetos y en embarazos de bajo riesgo y en 6.6 fetos de 100 en embarazos de alto riesgo.	***1++*** ***NICE*** *Karim JN, 2017*
Rc	Se recomienda realizar ultrasonido en caso de sospecha de malformaciones fetales u otro tipo de anomalías estructurales.	***A*** ***NICE*** *Karim JN, 2017*
✓	La mejor estimación obstétrica (uso de ultrasonido) debe ser utilizada para el cálculo de la edad gestacional, por sobre la fecha de última menstruación, con el fin de optimizar la vigilancia del embarazo; lo ideal es realizar el ultrasonido antes de las 22 semanas de gestación.	***PBP***
✓	El examen por ultrasonido es particularmente importante cuando la fecha de última menstruación no se conoce o es imprecisa, en pacientes que se embarazaron tomando anticonceptivos, y cuando el tamaño del útero no concuerda con la fecha de última menstruación.	***PBP***
	Maniobras de Leopold	
E	Un estudio prospectivo para analizar la precisión de las maniobras de Leopold para determinar la presentación cefálica y para identificar los factores que pueden influenciar la precisión, mostró que las maniobras de Leopold llevadas a cabo en el tercer trimestre del embarazo, tiene una alta sensibilidad, pero baja especificidad. La precisión de las maniobras de Leopold para determinar la presentación fetal y la posición fue de 89 y 96%, respectivamente. La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo fueron de 93.2, 30 y 94.9%, respectivamente. Una circunferencia abdominal grande disminuyó la precisión de las maniobras (OR 0.821, IC 95%, 0.703-0.959, p 0.13.	***2++*** ***NICE*** *Udompornthanakij P, 2020*
R	En caso de no contar con ultrasonido, se deben de utilizar las maniobras de Leopold para evaluar la presentación fetal.	***B*** ***NICE*** *Udompornthanakij P, 2020*

E	Un estudio de cohorte prospectivo, realizado en áreas de urgencias, que incluyó 50 pacientes, cuyo objetivo fue evaluar la necesidad de una exploración pélvica formal en mujeres que refieren molestias en etapas tempranas del embarazo, y que cuentan con embarazo intrauterino corroborado por ultrasonido, muestra que el examen pélvico no contribuyó a determinar el tratamiento obstétrico; no se realizaron cambios al manejo inicial después de la maniobra. Pueden existir patógenos cervicales ocultos en estas pacientes.	***1+*** ***NICE*** *Seymour A, 2010*
Rc	No se recomienda realizar exploración pélvica de forma rutinaria a mujeres embarazadas con molestias comunes en etapas tempranas del embarazo y con bajo riesgo.	**A** **NICE** *Seymour A, 2010*
✓	En algunos casos seleccionados, se puede realizar examen pélvico para detectar anormalidades en el tracto reproductor y para el tamizaje de infecciones de transmisión sexual.	**PBP**
	Exploración de mamas	
E	Un estudio longitudinal para determinar la prevalencia y características de las enfermedades de la glándula mamaria, en una cohorte de 1,248 mujeres embarazadas, encontró que el 17.9 % presentaban alguna patología mamaria y que el 11.9% ya tenían alguna patología previa al embarazo. 208 pacientes presentaban nódulos palpables o engrosamiento de las mamas, 28 pacientes presentaban dolor constante y 63 pacientes abscesos, infecciones o mastitis. 20 de 127 pacientes a las que se les realizó mamografía fueron clasificadas como BIRADS ≥ 3. No se encontró patología mamaria maligna en las biopsias guiadas por ultrasonido en estas pacientes.	***2+*** ***NICE*** *Odedina S, 2018*
R	No se recomienda la exploración mamaria de rutina en pacientes embarazadas, únicamente en casos seleccionados, para realizar el diagnóstico y tratamiento de nódulos mamarios y facilitar la detección temprana de cáncer de mama.	***B*** ***NICE*** *Odedina S, 2018*
	Medición de presión arterial	
E	Un estudio prospectivo observacional, en 8899 mujeres, que cursaban su primer embarazo, sin historial de hipertensión previa o diabetes, en las cuales se realizó una medición de TA en el primer trimestre y otra en el segundo trimestre, muestra que tener hipertensión estadio I, se	***2++*** ***NICE*** *Hauspurg A, 2019*

	cualquier trastorno hipertensivo durante el embarazo. (RR 1.41, IC 1.20-1.65) comparadas con las mujeres con decrementos en la presión sistólica.	
R	Se recomienda medir la presión arterial en cada visita a toda mujer embarazada, ya que esto permite identificar pacientes con hipertensión crónica o con enfermedad hipertensiva que se puede desarrollar durante el embarazo; estas patologías son en su mayoría asintomáticas.	***B*** ***NICE*** *Hauspurg A, 2019*
	Enfermedad periodontal	
E	Una evaluación de revisiones sistemáticas que estudiaron la asociación de enfermedad periodontal y desenlaces adversos durante el embarazo muestra una asociación positiva entre: • Enfermedad periodontal y embarazo pretérmino (RR 1.6, IC 95%, 1.3 a 2.0, 17 estudios, 6,741 participantes). • Preeclampsia (OR 2.2, IC 95%, 1.4 a 3.4, 15 estudios, 5,111 participantes) • Bajo peso al nacer en embarazo pretérmino (RR 3.4, IC 95%, 1.3 a 8.8, 4 estudios, 2,263 participantes)	***1++*** ***NICE*** *Daalderop L, 2016*
Rc	Se recomienda que a todas las mujeres embarazadas se les realice exploración bucofaríngea en la primera visita prenatal, ya que la presencia de enfermedad periodontal se asocia con un incremento en el riesgo de desarrollar preeclampsia, tener un embarazo pretérmino, y tener un bebé con bajo peso.	***A*** ***NICE*** *Daalderop L, 2016*
	Gonadotrofina coriónica humana en sangre u orina	
E	La detección de la fracción beta de gonadotropina coriónica humana tiene mayor sensibilidad y especificidad al hacerla en sangre comparada con hacerla en orina. La detección en orina, sin embargo, es más económica, cómoda y rápida. Los resultados se reportan en unidades mili internacionales de la hormona hCG por mililitro de sangre, o mIU/mL. También se utiliza unidades internacionales por litro (IU/L). Pueden medir niveles tan bajos como 1 a 2 mIU/mL. Una prueba negativa se reporta con hCG < 1 (IU/mL).	*4* *NICE* *Betz D, 2021*

	inducciones en el grupo de ultrasonido temprano, y hubo mejoría en varios desenlaces perinatales también para el grupo del ultrasonido temprano.	
	La medición ultrasonográfica del embrión o feto en el primer trimestre (hasta las 12 semanas de gestación) es el método más preciso para establecer o confirmar la edad gestacional.	***B*** ***NICE*** *Verburg BO, 2008* *Caughey AB, 2008*
	Se debe asignar la fecha probable de parto y la edad gestacional, tan pronto se obtenga la fecha de última menstruación, el primer examen por ultrasonido, o ambos. Se debe discutir esto con la paciente, y documentarlo claramente en la nota médica.	***B*** ***NICE*** *Verburg BO, 2008* *Caughey AB, 2008*
	Se considera una estimación subóptima de la fecha probable de parto de un embarazo, el calcularla sin un ultrasonido antes de las 22 semanas de gestación.	***B*** ***NICE*** *Verburg BO, 2008* *Caughey AB, 2008*
	No se recomienda calcular la edad gestacional por ultrasonido después de las 28 semanas de gestación, ya que ésta es la manera menos precisa para hacerlo y puede ocasionar subestimación de la edad gestacional ante un caso de retraso en el crecimiento intrauterino. Puede variar el cálculo de la fecha de parto en +/- 21 a 30 días.	**PBP**

E	usar magnesio oral con placebo, un ensayo compare Vitamina B con placebo, y otro calcio vía oral con vitamina C, se muestra que, con el uso de magnesio vía oral, hubo reducción del 50% en la frecuencia de los calambres. (RR 1.42, IC 95% CI 1.09 a 1.86. Con los suplementos de magnesio la evidencia no fue concluyente. Con el uso de calcio oral hubo una reducción en la aparición de calambres. (RR 8.59, IC 95%, 1.19 a 62.07)	**1++** **NICE** *Zhou K, 2015*
Rc	Se puede utilizar calcio 1 g vía oral dos veces al día, o magnesio 300 a 360 mg dos o tres veces al día, durante 2 a 4 semanas, para el manejo de los calambres durante el embarazo.	**A** **NICE** *Zhou K, 2015*
✓	Existen otras alternativas que, aunque no cuentan con evidencia sólida, pueden recomendarse de acuerdo con las preferencias de las pacientes, como relajación muscular, masajes, terapia con calor, y la dorsoflexión del pie.	**PBP**
	Dolor de espalda baja y dolor pélvico	
E	Una revisión sistemática de 34 ensayos clínicos, con 5121 mujeres embarazadas, de 16 a 45 años de edad, para actualizar la evidencia que evalúa los efectos de cualquier intervención usada para prevenir y tratar el dolor de espalda baja y el dolor pélvico durante el embarazo, muestra que, derivado de evidencia de baja calidad, cualquier ejercicio en el suelo, reduce significativamente el dolor (diferencia de medias -0.64, IC 95%, -1.03 a -0.25) y la discapacidad funcional (diferencia de medias -0.56, IC 95%, -0.89 a -0.23. Además, está demostrado que el ejercicio en el embarazo contribuye a reducir la ganancia de peso excesivo durante el mismo.	**1++** **NICE** *Liddle SD, 2015*
Rc	Se recomienda realizar ejercicio durante el embarazo, como yoga o aqua aerobics, durante 8 a 12 semanas, en pacientes con dolor de espalda baja o dolor pélvico, y se puede utilizar además fisioterapia, cinturones de soporte, y acupuntura, de acuerdo con las preferencias de las pacientes.	**A** **NICE** *Liddle SD, 2015*
✓	No se debe recomendar ejercicio a mujeres con disfunción de la sínfisis del pubis, ya que puede exacerbar el dolor pélvico asociado.	**PBP**

Documento de origen: GPC Atención y cuidados multidisciplinarios en el embarazo.pdf

	No existe evidencia de buena calidad para recomendar otras terapias alternativas como manipulación quiropráctica u osteopática, TENS (estimulación transcutánea eléctrica del nervio), relajación progresiva muscular, y terapia craneosacra.	**PBP**
	Estreñimiento	
	Una revisión sistemática de ensayos clínicos, de calidad moderada, con 180 mujeres, para evaluar la eficacia y seguridad de intervenciones tanto farmacológicas como no farmacológicas, para tratar el estreñimiento durante el embarazo, muestra que, comparado con laxantes formadores de masa (salvado de trigo o de avena, esterculia, metilcelulosa, psyllium rubio o ispagul), las mujeres que tomaron laxantes estimulantes (compuestos de sen) presentaron mejoría en el estreñimiento (RR 1.59, IC 95%, 1.21 a 2.09), pero presentaron más molestias abdominales (RR 2.33, IC 95%, 1.15 a 4.73), y una diferencia apenas perceptible en diarrea (RR 4.50, IC 95%, 1.01 a 20.09)	**1++** **NICE** *Rungsiprakarn P, 2015*
	Se le debe recomendar a toda mujer embarazada que curse con estreñimiento, como tratamiento de primera línea, aumentar la ingesta de agua y fibra (que se encuentra en vegetales, nueces, frutas y granos), y en caso de que no presente mejoría, se pueden recomendar suplementos de fibra o salvado de trigo.	**A** **NICE** *Rungsiprakarn P, 2015*
	Siempre se debe recomendar como medida inicial para el tratamiento del estreñimiento durante el embarazo, aumentar la ingesta de agua y fibra antes de recomendar otras opciones terapéuticas.	**PBP**
	Várices y edema	
	Una revisión sistemática, para evaluar la eficacia de varias intervenciones (rutosida, masajes, compresión neumática intermitente externa, sumersión en agua a una temperatura entre 29 y 33°C, elevación de miembros inferiores y reflexología) para aliviar la sintomatología asociada a las várices y el edema durante el embarazo, muestra que los rutósidos redujeron significativamente la sintomatología asociada a las várices (RR 1.89, IC 95%, 1.11 a 3.22). La compresión neumática comparada con descanso no mostró mejoría, la reflexología si redujo la sintomatología (RR 9.09, IC 95%, 1.41 a 58.54), el masaje no reporta mejoría, y la inmersión en agua durante 20 minutos comparada con la elevación de miembros inferiores si reporta mejoría (RR 0.43, IC 95%, 0.22 a 0.83).	**1++** **NICE** *Smyth R, 2015*

Imagen 46/66: GPC_Atención_y_cuidados_multidisciplinarios_en_el_embarazo.pdf-0050-00.png

Rc	Se puede recomendar el uso de rutósidos, la inmersión en agua durante 20 minutos y la reflexología para el tratamiento de la sintomatología asociada a várices y edema de miembros inferiores durante el embarazo.	**A** **NICE** *Smyth R, 2015*
✓	Se recomienda iniciar con las intervenciones más simples, de bajo costo y seguras, como la elevación de miembros inferiores, la inmersión en agua y el reposo para el tratamiento de la sintomatología asociada a várices y edema de miembros inferiores durante el embarazo.	**PBP**

	Trichomona vaginalis	
E	Una revisión sistemática de 19 estudios, para dilucidar la asociación entre la tricomoniasis en mujeres embarazadas y los desenlaces adversos al nacimiento, que incluyen parto pretérmino, ruptura prematura de membranas y bajo peso al nacer, muestra que existen asociaciones significativas entre tricomoniasis y parto pretérmino (OR 1.27; IC 95%, 1.08-1.50), ruptura prematura de membranas (OR 1.87; IC 95%, 1.53-2.29) y bajo peso al nacer (OR 2.12; IC 95%, 1.15-3.91).	***1++*** ***NICE*** *Van Gerwen O, 2021*
E	Una revisión de ensayos clínicos aleatorizados multicéntricos a lo largo de 30 años, acerca del tratamiento de Trichomona vaginalis tanto en mujeres sanas, con VIH y en hombres, muestra que la opción más eficaz de tratamiento es el metronidazol. Como alternativa de tratamiento se sugiere dosis única de metronidazol o tinidazol de 2 gramos. Las mujeres que recibieron el esquema de 7 días tuvieron 50% menos probabilidades de salir positivas nuevamente que las que recibieron el esquema de dosis única.	***1+*** ***NICE*** *Van Gerwen O, 2019*
Rc	Se recomienda dar tratamiento con Metronidazol vía oral 500 mg dos veces al día durante 7 días a la mujer embarazada con infección por Trichomona.	***A*** ***NICE*** *Van Gerwen O, 2019*

Documento de origen: GPC Atención y cuidados multidisciplinarios en el embarazo.pdf

E	La definición de anemia en el embarazo es la siguiente: Primer trimestre: hemoglobina < 11 mg/dl (Hto < 33%) Segundo trimestre: hemoglobina < 10.5 g/dl (Hto < 32%) Tercer trimestre: hemoglobina < 11 g/dl (Hto < 33%) Posparto: hemoglobina < 10 mg/dl (Hto < 30%)	**4** **NICE** *ACOG 2021*
E	Una revisión sistemática con metaanálisis para analizar la relación entre la anemia materna y el bajo peso al nacer, que incluyó 71 artículos de los cuales 68 fueron incluidos en el metaanálisis, muestra que la anemia materna se asocia a un peso bajo al nacer con un OR ajustado de 1.23, IC 95%, 1.06 a 1.43, y una I^2 de 58%. Las meta-regresiones confirman que el tamaño de la muestra y la calidad metodológica pueden explicar parcialmente la heterogeneidad estadística. La anemia materna se considera un factor de riesgo para bajo peso al nacer.	**1+** **NICE** *Figueiredo A, 2018*
E	Otra revisión sistemática para determinar la relación entre la anemia materna durante el embarazo y el parto pretérmino, que incluyó 18 ensayos clínicos con una muestra de 932,090 pacientes, muestra que la relación es significativa (1.56 [IC 95%: 1.25-1.95]). La anemia materna en el primer trimestre aumenta el riesgo de parto prematuro (RR 1.65 [IC 95%: 1.31-2.08]). Pero, esta relación no es significativa en el segundo (RR, 1.45 [IC 95%: 0.79-2.65]) ni en el tercer trimestre (RR 1.43 [IC 95%: 0.82-2.51])	**1++** **NICE** *Rahmati S, 2020*
Rc	Se debe tratar la anemia en la mujer embarazada ya que el presentar anemia condiciona bajo peso al nacer y parto pretérmino, sobre todo cuando la anemia se presenta en el primer trimestre del embarazo.	**A** **NICE** *Rahmati S, 2020*
	Deficiencia de hierro	
E	Una revisión sistemática con metaanálisis, de 11 ensayos clínicos aleatorizados, para evaluar los beneficios del tratamiento con hierro intravenoso en el embarazo, en pacientes con anemia por deficiencia de hierro, muestra que las mujeres que fueron tratadas con hierro intravenoso lograron los siguientes beneficios: 1)alcanzaron el objetivo propuesto de hemoglobina un mayor número de veces (OR 2.66, IC 95%, 1.71-4.15) 2) incrementaron el nivel de hemoglobina después de 4 semanas WMD 0.84 g/dl, IC 95%, 0.59 a 1.09, p<0.001) 3) disminuyó el número de eventos adversos (OR 0.35, IC 95%, 0.18 a 0.67)	**1++** **NICE** *Govindappagari S, 2018*

Imagen 49/66: GPC_Atención_y_cuidados_multidisciplinarios_en_el_embarazo.pdf-0055-00.png

Rc	Se recomienda tratar a las mujeres con anemia por deficiencia de hierro con hierro intravenoso para alcanzar los objetivos de hemoglobina en un tiempo menor y con una menor cantidad de eventos adversos.	**A** **NICE** *Govindappagari S, 2018*
E	Una revisión sistemática de 9 ensayos clínicos con 910 pacientes para evaluar la eficacia y seguridad de diversas formulaciones de hierro intravenoso, carboximaltosa férrica y sacarosa de hierro, en mujeres embarazadas y pacientes ginecológicas con anemia por deficiencia de hierro, muestra que las pacientes que recibieron carboximaltosa férrica presentaron un nivel mayor de hemoglobina (MD, 0.67; IC 95%, 0.25-1.08; I2 = 92%; P = 0.002) y de ferritina (MD, 24.41; IC 95%, 12.06-36.76; I2 = 75%; P = 0.0001) que las pacientes que recibieron sacarosa. El grupo de pacientes de carboximaltosa férrica muestra una menor incidencia de eventos adversos después del tratamiento con hierro que el grupo de sacarosa. (RR 0.53; IC 95%, 0.35-0.80; I2 = 0%; P = 0.003. No se reportaron eventos adversos serios en ninguno de los dos grupos.	**1+** **NICE** *Hye Won Shin, 2021*
R	Se recomienda, como primera elección, administrar carboximaltosa férrica para el tratamiento de las pacientes con anemia por deficiencia de hierro.	**A** **NICE** *Hye Won Shin, 2021*
	Anemia megaloblástica (deficiencia de folatos y de Vitamina B12)	
E	Tener bajos niveles de folato se asocia con un incremento en el riesgo de desenlaces de salud adversos, lo que incluye anemia megaloblástica y defectos del tubo neural que afectan el embarazo. El folato es esencial para la síntesis de DNA, para el crecimiento celular y la diferenciación, así como para la formación y maduración de células rojas sanguíneas. El folato es particularmente crítico en las primeras etapas de un embarazo. Los bajos niveles de folato se asocian con otros desenlaces adversos, como defectos cardiacos congénitos, fisuras orales, restricción en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, y parto pretérmino.	**2+** **NICE** *Chen MY, 2019*
E	Un estudio que evaluó desenlaces favorables con la suplementación de ácido fólico, que incluyó 215 mujeres embarazadas, muestra que la concentración de ácido fólico en la sangre materna fue significativamente mayor después de la suplementación con ácido fólico (24.6 ng/ml vs.11.8 ng/ml. En contraste, el nivel de homocisteína en la sangre materna disminuyó con la suplementación (5.5 µmol/ml vs. 6.8 µmol/ml). Los porcentajes de preeclampsia (OR, 0.27; IC 95%, 0.09-0.76) y de bajo peso al nacer (bajo peso; 9.2% vs. 20.0%; OR, 0.42; IC 95%, 0.18-0.99) fueron menores en el	**2+** **NICE** *Min Woo Kim, 2014*

	La diferencia entre el diámetro del saco gestacional y de la longitud cefalocaudal menor a 5 mm se asocia a un mayor riesgo de aborto (OR 4.88)	
Rc	Se recomienda realizar ultrasonido en mujeres embarazadas con factores de riesgo y en aquellas que presenten sangrado transvaginal, para descartar la posibilidad de aborto.	**B** **NICE** *Datta MR, 2017*
	Preeclampsia-Eclampsia	
E	Enfermedad multisistémica que complica del 3 al 8% de todos los embarazos. La incidencia de esta enfermedad se ha incrementado un 25% en los últimos 20 años, y la hospitalización se asocia con un aumento en el riesgo para la morbilidad y mortalidad materna y fetal. Se diagnostica por la presencia de hipertensión y proteinuria.	**4** **NICE** *Witcher PM, 2018*
E	La preeclampsia es una enfermedad del embarazo que se asocia con la aparición de hipertensión, que ocurre con mayor frecuencia después de las 20 semanas de gestación y frecuentemente muy cerca del término de la gestación. Los criterios diagnósticos son los siguientes: **Presión arterial:** • Presión arterial sistólica de 140 mm Hg o más ó presión arterial diastólica de 90 mm Hg o más en dos ocasiones al menos con 4 horas de diferencia después de 20 semanas de gestación en una mujer con presión arterial normal previa. • Presión arterial sistólica de 160 mm Hg o más ó presión arterial diastólica de 110 mm Hg o más. (La hipertensión grave se puede confirmar con un intervalo corto (minutos) para facilitar el tratamiento antihipertensivo oportuno. Y **Proteinuria:**	**4** **NICE** *Bernstein PS, 2017*

	• Cefalea de nueva aparición que no responde a tratamiento farmacológico y que no corresponde a diagnósticos alternativos o a síntomas visuales.	
E	El tratamiento definitivo de la preeclampsia es la extracción del producto del embarazo y la placenta, y esto depende de la gravedad de la enfermedad y de la edad gestacional.	**4** **NICE** *Witcher PM, 2018*
E	Un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con 11,976 mujeres a las que se les asignó de forma aleatoria una dosis baja de aspirina (5,990 mujeres) o placebo (5,986 mujeres) muestra que tuvieron parto pretérmino 668 de las que tomaron aspirina vs 754 de las que tomaron placebo. (RR 0.89, IC 95%, 0.81 a 0.98). En las mujeres que tomaron aspirina, se muestra una reducción significativa en la mortalidad perinatal (0.86, 0.73 a 1.00, p=0.048), pérdidas fetales (0.86, 0.73 a 1.00, p=0.039), parto pretérmino (< 34 semanas 0.75, 0.61 a 0.93, p=0.039), y en la incidencia de mujeres con parto antes de la semana 34 y con enfermedad hipertensiva del embarazo (0.38, 0.17 a 0.85, p=0.015)	**1++** **NICE** *Hoffman MK, 2020*
E	Un ensayo clínico aleatorizado con 1,105 mujeres de alto riesgo que fueron aleatorizadas a recibir placebo o aspirina en tres subgrupos (25, 50 y 75 mg), tomando aspirina a partir de la semana 12 diario por las noches, muestra una relación linear entre la dosis de aspirina y la incidencia de preeclampsia y preeclampsia temprana (p<0.05). La incidencia de preeclampsia y de preeclampsia temprana se correlacionó de forma negativa con la dosis de aspirina.	**1++** **NICE** *Gu W, 2020*

Rc	Se recomienda que todas las mujeres con factores de riesgo para preeclampsia (embarazo previo con preeclampsia, enfermedad renal, enfermedad autoinmune, Diabetes tipo 1 o tipo 2, e hipertensión crónica) y aquellas con más de un factor de riesgo moderado (primer embarazo, edad materna > 35 años, IMC > 30, antecedente familiar de preeclampsia, características sociodemográficas) se les indique una dosis baja (81 mg/día) de aspirina como prevención de preeclampsia, e iniciarla entre la semana 12 y la 28 de la gestación (idealmente antes de la semana 16) y debe continuar durante todo el embarazo.	**A** **NICE** *Hoffman MK, 2020* *Gu W, 2020*
✓	En caso de detectar un caso de preeclampsia, se deberá referir inmediatamente a segundo nivel de atención para recibir manejo especializado.	**PBP**
	Parto prematuro	
E	El parto pretérmino se define según la OMS como el nacimiento antes de las 37 semanas de gestación. Alrededor de un 85% de estos nacimientos caen en moderados (32.33 semanas) a pretérminos tardíos (34-36 semanas). 10% son de bebés pretérmino (28-31 semanas) y 5% son de pretérminos extremos (< 28 semanas). Cada año, alrededor de un millón de bebés mueren de prematurez, y muchos que sobreviven lo hacen con alguna discapacidad. En todo el mundo, alrededor de 15 millones de bebés nacen con prematurez, con una tendencia a aumentar en las últimas dos décadas. Existe una gran cantidad de evidencia de que el ultrasonido transvaginal en la mitad del embarazo es un método muy útil para predecir la probabilidad de parto pretérmino tanto en embarazos únicos como en embarazos gemelares, y muchos estudios en la última década muestran que la administración de progestágenos en mujeres de alto riesgo con un embarazo único disminuye a la mitad la probabilidad de un parto pretérmino espontáneo.	**4** **NICE** *Da Fonseca EB, 2020*
E	Un meta análisis de 19 ensayos clínicos, para evaluar la eficacia de los progestágenos para prevenir el parto pretérmino en mujeres con antecedentes de parto pretérmino espontáneo, gestaciones múltiples, cérvix corto, trabajo de parto pretérmino, u otras indicaciones, muestra que, en mujeres con parto pretérmino previo y embarazos	**1++** **NICE** *Likis FE, 2012*

	uso de un protocolo anatómico estandarizado de tamizaje de anomalías en el primer trimestre y de su sensibilidad para la detección de anomalías fetales en todos los subgrupos.	
Rc	Se recomienda realizar ultrasonido en etapas tempranas del embarazo (antes de la semana 24 de gestación) a las mujeres que presenten factores de riesgo para anomalías genéticas.	**A** **NICE** *Whitworth M, 2015*
✓	Se deberá referir al siguiente nivel de atención, para diagnóstico genético, a la paciente que por sus antecedentes lo amerite.	**PBP**
	Anormalidades de situación y presentación fetales	
E	Las anormalidades en la presentación fetal incluyen nalgas, hombro, compuesta, cara, y cejas. Los factores de riesgo para una mala posición fetal incluyen múltiples factores maternos y fetales, como el tamaño del producto, el volumen de líquido amniótico, anomalías fetales, habitus materno, y estructura pélvica. La presentación de nalgas es la anomalía más común y se puede manejar con versión cefálica externa o con cesárea. El parto vaginal en estos casos se asocia con malos desenlaces perinatales y solo debe considerarse en casos seleccionados.	**4** **NICE** *Pilliod R, 2017*
E	La mala posición fetal incluye occipital posterior y occipital transversa, es un problema común en obstetricia y se diagnostica en el trabajo de parto activo por medio de examen clínico o ultrasonido. La mayoría de estos casos se resuelven rotando de manera espontánea a occipital	**4** **NICE** *Pilliod R, 2017*

	casos pueden persistir y se deben manejar con rotación digital o manual, lo que representa grandes tasas de éxito y efectos adversos mínimos.	
R	En caso de detectar estas anomalías después de la semana 35, y con trabajo de parto, se recomienda enviar inmediatamente al siguiente nivel de atención para valoración.	**D** **NICE** *Pilliod R, 2017*
✓	En la consulta más cercana al término de la gestación, se recomienda que el Médico Familiar lleve a cabo una cuidadosa exploración abdominal para identificar anormalidades y, en caso de hacerlo, referir al siguiente nivel de atención.	**PBP**
	Ruptura Prematura de Membranas	
E	La ruptura prematura de membranas fetales se define como aquella que ocurre antes de haberse iniciado el trabajo de parto; puede ser previa a la semana 37 de gestación en cuyo caso recibe el nombre de ruptura prematura de membranas pretérmino, la cual aumenta la morbilidad y mortalidad tanto materna como perinatal.	**4** **NICE** *López-Osma F, 2006*
E	Un estudio de cohorte retrospectivo en 510 embarazos (114 gemelares y 396 únicos) para evaluar desenlaces perinatales en casos de ruptura prematura de membranas antes de la semana 34 de gestación, muestra que ocurrió corioamnioitis en el 17.8%, la mortalidad neonatal fue de 7.4%, la probabilidad de un problema neonatal grave fue de 40%, y la probabilidad de admisión a una unidad de cuidados intensivos neonatales fue de 72.9%. El periodo de latencia excedió las 48 horas en 62.5% de los embarazos y 7 días en el 24.3% de los embarazos. Los embarazos gemelares tuvieron un periodo de latencia menor que los embarazos únicos (media de 2 días comparado con media de 4 días, $p < 0.001$. Los embarazos que se complicaron con sangrado vaginal temprano tuvieron una alta mortalidad neonatal (13.95% vs 6.36%) y morbilidad (51.15% vs 38.32%). Los análisis multivariados de regresión logística muestran una asociación con la mortalidad y morbilidad neonatal. La edad gestacional al momento de lo ruptura prematura de membranas, los embarazos gemelares, y el periodo de latencia se asocian con la mortalidad y morbilidad neonatal.	**2++** **NICE** *Yu H, 2015*
Rc	Se recomienda referir e iniciar manejo inmediato por ginecoobstetra en las pacientes que presentan ruptura prematura de membranas ante la posibilidad de desarrollar corioamnioitis, u otros problemas graves que aumentan la morbilidad y mortalidad neonatal.	**B** **NICE** *Yu H, 2015*

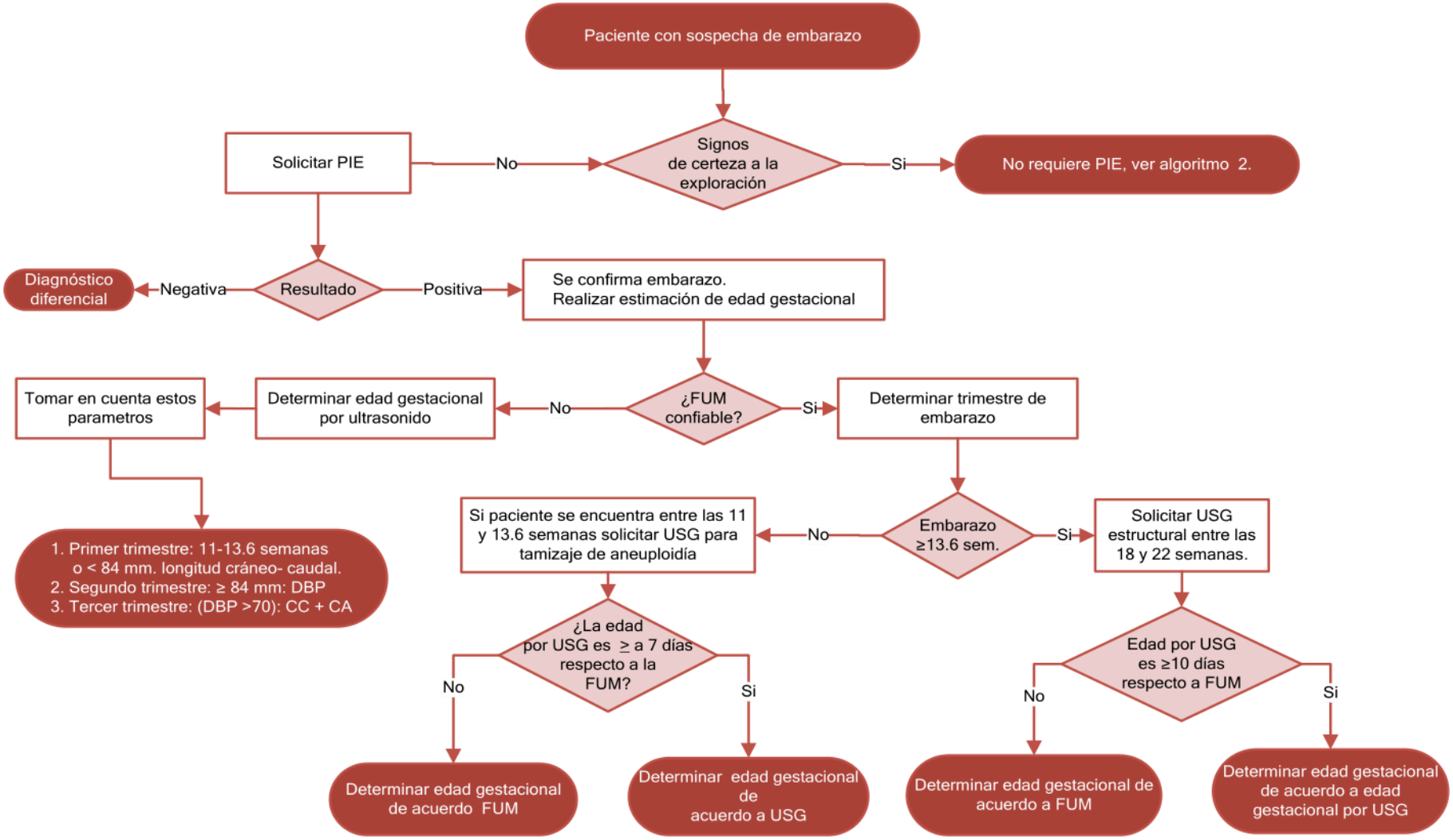


Imagen 56/66: GPC_Atención_y_cuidados_multidisciplinarios_en_el_embarazo.pdf-0068-04.png

Documento de origen: GPC Atención y cuidados multidisciplinarios en el embarazo.pdf

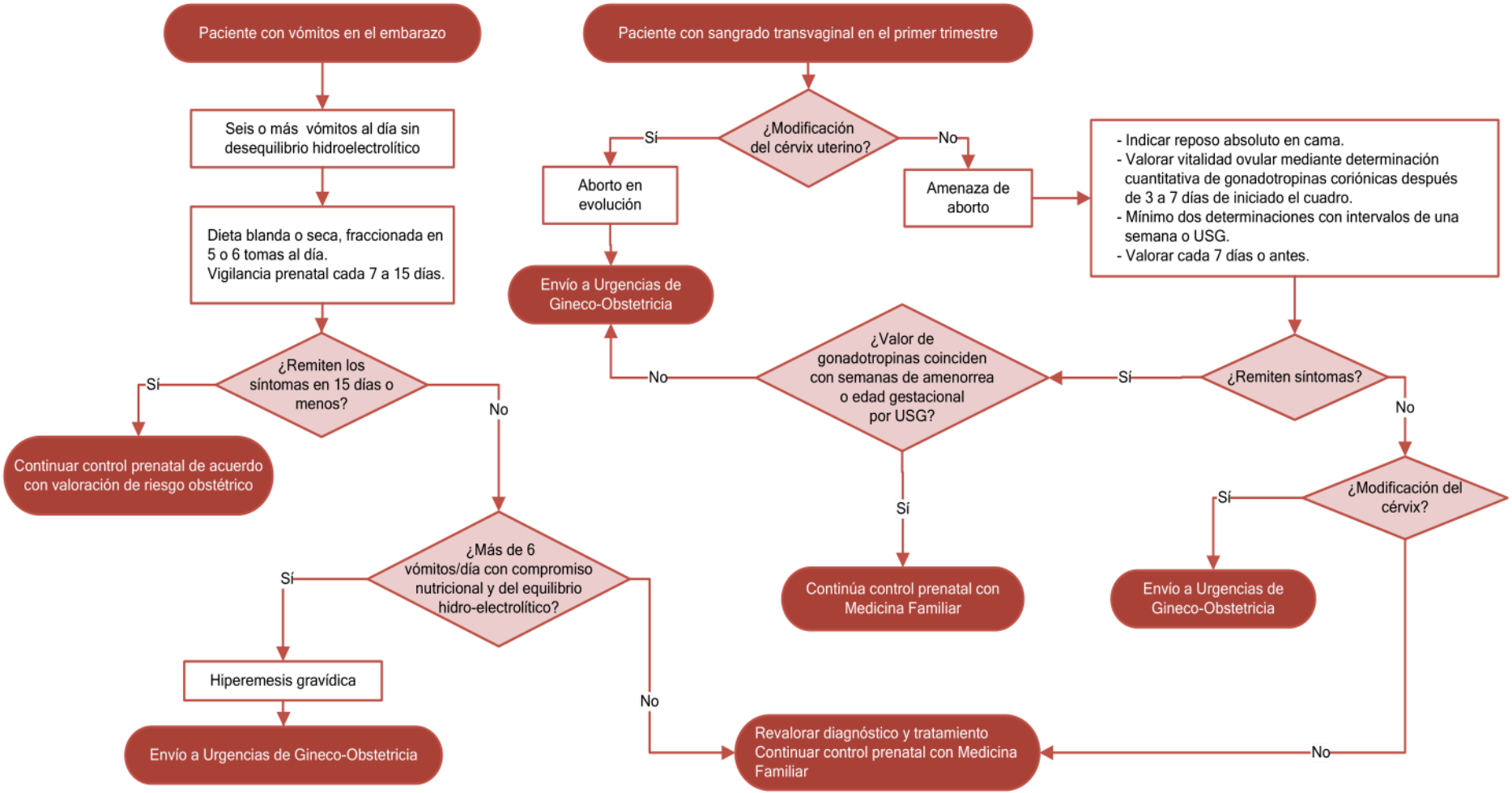


Imagen 57/66: GPC_Atención_y_cuidados_multidisciplinarios_en_el_embarazo.pdf-0069-02.png

Documento de origen: GPC Atención y cuidados multidisciplinarios en el embarazo.pdf

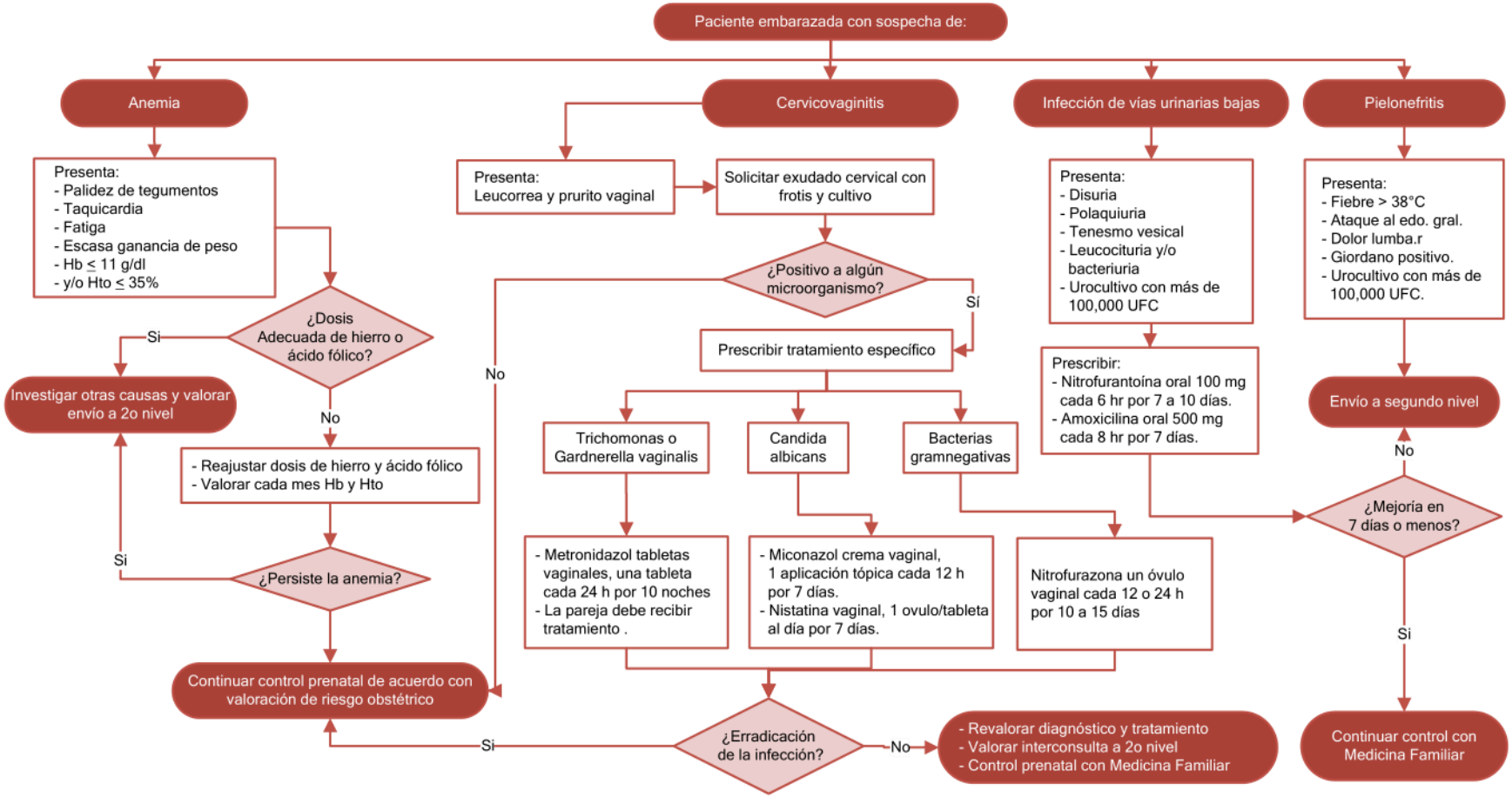


Imagen 58/66: GPC_Atención_y_cuidados_multidisciplinarios_en_el_embarazo.pdf-0070-02.png

Documento de origen: NOM-007-SSA2-2016 Embarazo, parto y puerperio.pdf

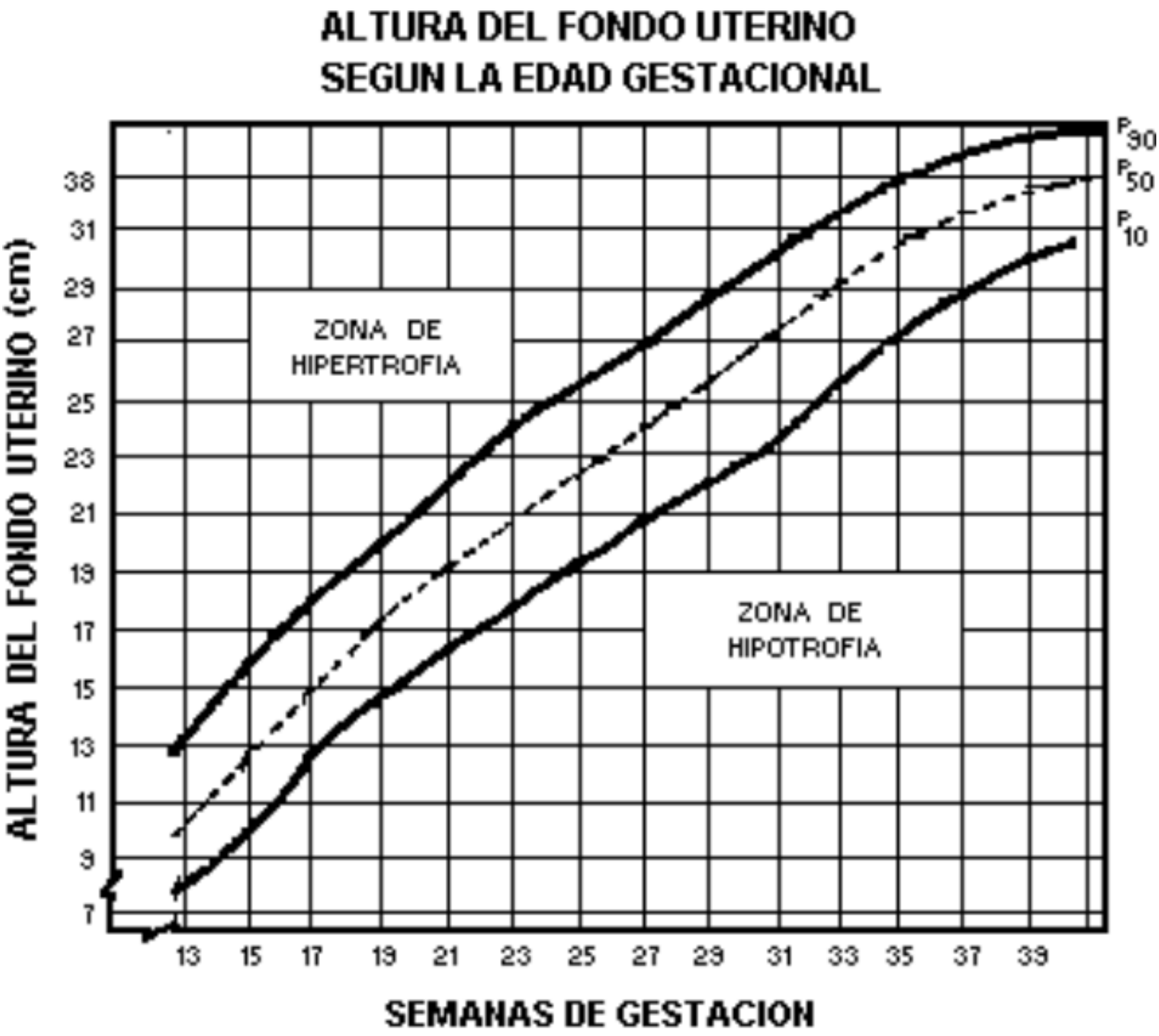


Imagen 59/66: NOM-007-SSA2-2016_Embarazo,_parto_y_puerperio.pdf-0049-00.png

	bajo peso
menos de 18.5 kg/m²	peso ideal
18.5 a 24.9	sobrepeso
25 a 29.9	obesidad leve
30 a 34.9	obesidad media
35 a 39.9	obesidad mórbida
Más de 40	

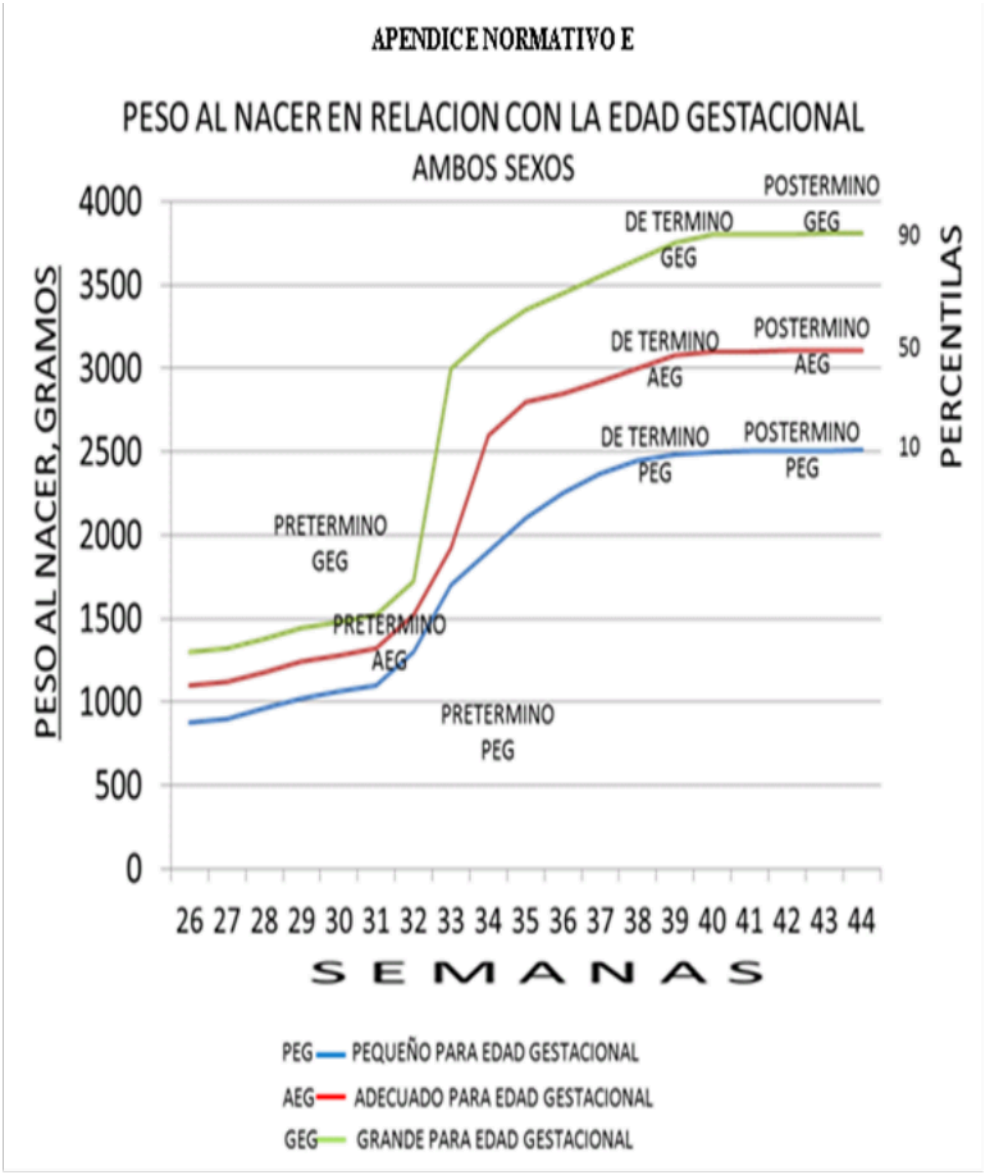


Imagen 61/66: NOM-007-SSA2-2016_Embarazo,_parto_y_puerperio.pdf-0057-00.png

Documento de origen: NOM-007-SSA2-2016 Embarazo, parto y puerperio.pdf

SOMÁTICO Y NEUROLÓGICO K= 200 días

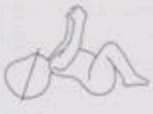
A	SOMÁTICO K= 204 días	Forma del pezón	Pezón apenas visible. No se visualiza areola 0	Pezón bien definido areola 0.75 cm 5	Areola bien definida. No sobresaliente, 0.75 cm 10	Areola sobresaliente, 0.75 cm 15	
B		Textura de la piel	Muy fina gelatinosa 0	Fina y lisa 5	Lisa y moderadamente gruesa. Descamación superficial 10	Gruesa, rigida, surcos superficiales. Descamación superficial 18	Gruesa y apergaminada 22
		Forma de la oreja	Plana y sin forma 0	Inicio engrosamiento del borde 5	Engrosamiento incompleto sobre mitad anterior 10	Engrosada e incorvada totalmente 24	
		Tamaño del tejido mamario	No palpable 0	Diámetro 0.5 cm 5	Diámetro 0.5-1.0 cm 10	Diámetro >1.0 cm 15	
		Pliegues plantares	Ausentes 0	Pequeños surcos rojos en mitad anterior 5	Surcos rojos definidos en mitad ant. surcos 1/3 anterior 10	Surcos sobre mitad anterior 15	Surcos profundos que sobrepasan 1/2 anterior 20
		Signo "de la bufanda"	 0	 6	 12	 18	
		Signo "cabeza en gota"	 0	 4	 8	 12	

Imagen 62/66: NOM-007-SSA2-2016_Embarazo,_parto_y_puerperio.pdf-0063-00.png

Antecedentes

U. Médica | Edad | FUM | Confiable si no

FPP | Grupo y Rh: Madre | Padre | Gestas | Partos | Cesáreas | Abortos

Ectópicos | Izq. | Der. | Talla | Peso antes del embarazo | Peso ideal | Hijos vivos

No.	Fecha nacimiento	Sem. gest. al nacim.	Peso	Vivo/Óbito/ M.perinatal	Complicaciones	
					Madre	Hijo

Vigilancia del embarazo

Primer trimestre

Citas fecha	Sem. gest.	Peso	T/A	Fondo uterino	Signos y síntomas				
					Dolor abd.	Vómito	Urinaria	Vaginal	Edema

Segundo trimestre

Citas fecha	Sem. gest.	Peso	T/A	Fondo uterino	FCF	Signos y síntomas				
						Dolor abd.	Mov. fetal	Urinaria	Vaginal	Edema

Tercer trimestre

Citas fecha	Sem. gest.	Peso	T/A	Fondo uterino	FCF	Signos y síntomas				
						Activuterina	Mov. fetal	Urinaria	Vaginal	Edema

Tratamientos

Diagnóstico	Medicamentos	Dosis

Segundo trimestre

Diagnóstico	Medicamentos	Dosis

Tercer trimestre

Diagnóstico	Medicamentos	Dosis

Exámenes

VDRL | Tamiz de glucosa | Cervicovag

Fecha	Ht	Hb	Urea	Creatinina	Orina	Glu	Otros

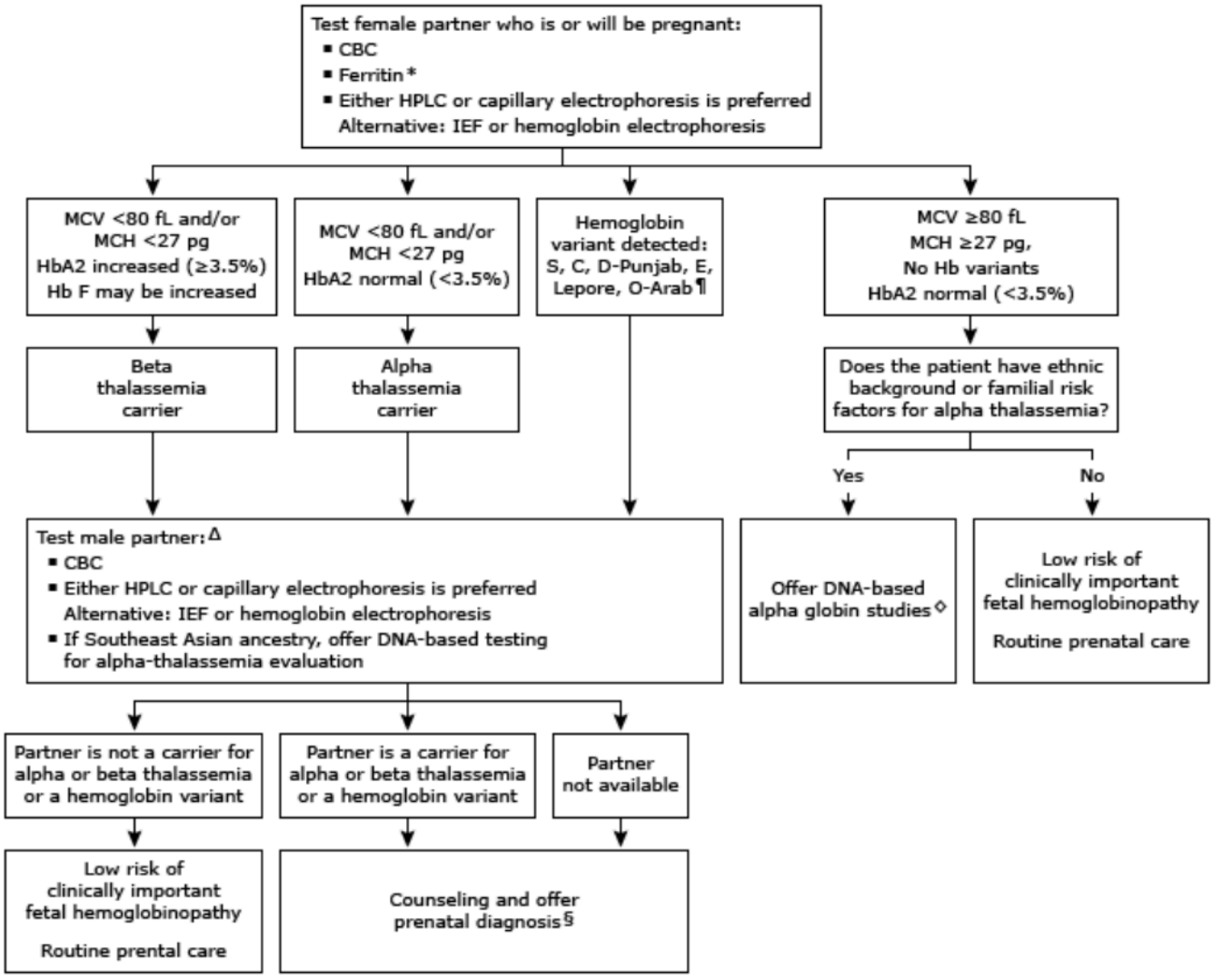
Ultrasonografía

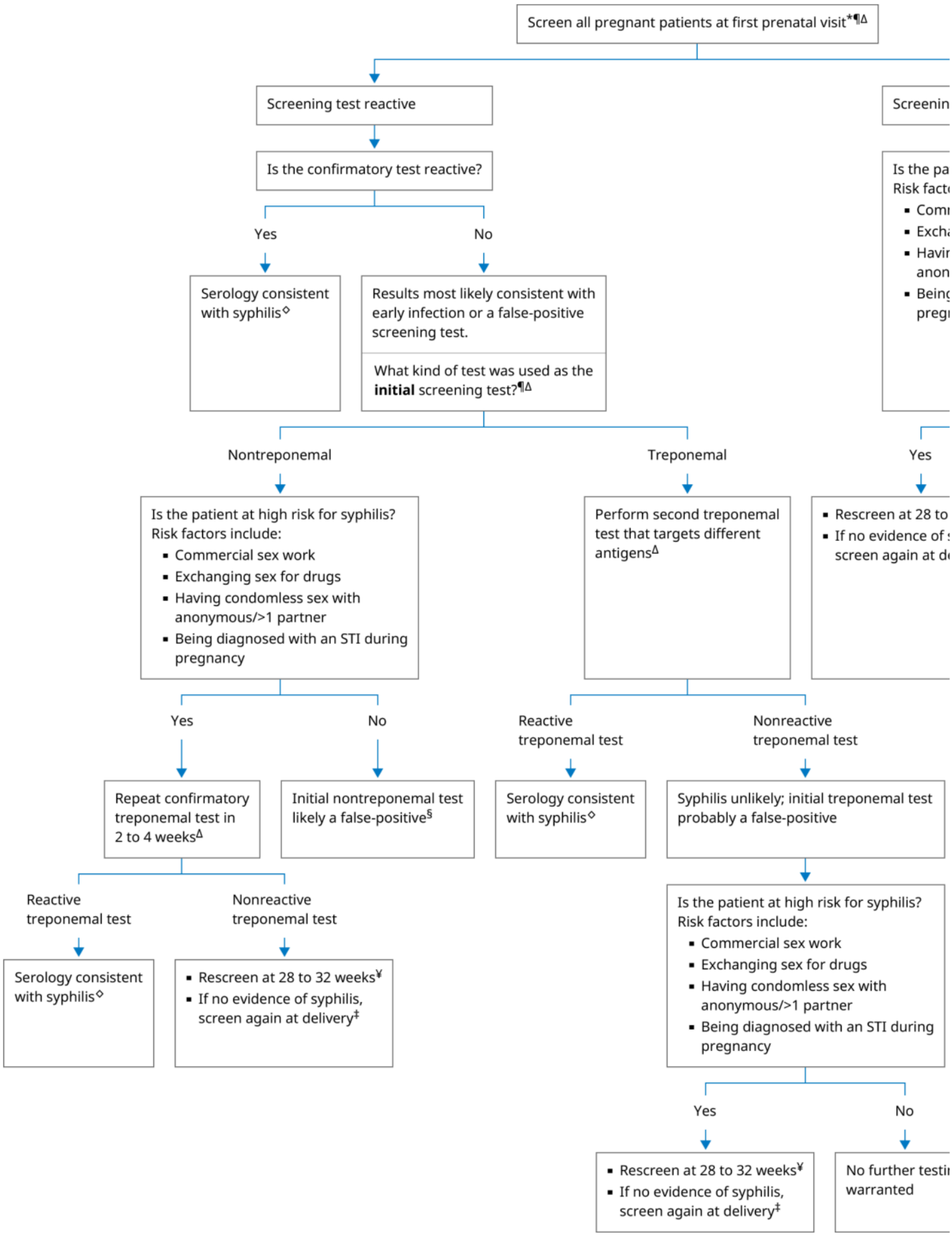
Embarazo: Único | Múltiple | 1° trim. | Fecha | Reporte

Fecha	DBP	L.F.	C.C.	C.A.	Local placentaria	Liq. amniótico	Observaciones

Identificación de factores de riesgo

Fecha	Curso normal	Alto riesgo (anotar los factores de riesgo)	Manejo


Test female partner who is or will be pregnant:
CBC
Ferritin*
Either HPLC or capillary electrophoresis is preferred
Alternative: IEF or hemoglobin electrophoresis
MCV <80 fL and/or MCH <27 pg HbA2 increased (≥3.5%) Hb F may be increased
MCV <80 fL and/or MCH <27 pg HbA2 normal (<3.5%)
Hemoglobin variant detected: S, C, D-Punjab, E, Lepore, O-Arab¶
MCV ≥80 fL MCH ≥27 pg, No Hb variants HbA2 normal (<3.5%)
Beta thalassemia carrier
Alpha thalassemia carrier
Does the patient have ethnic background or familial risk factors for alpha thalassemia?
Yes
No
Test male partner:Δ
CBC
Either HPLC or capillary electrophoresis is preferred
Alternative: IEF or hemoglobin electrophoresis
If Southeast Asian ancestry, offer DNA-based testing for alpha-thalassemia evaluation
Offer DNA-based alpha globin studies◊
Low risk of clinically important fetal hemoglobinopathy
Routine prenatal care
Partner is not a carrier for alpha or beta thalassemia or a hemoglobin variant
Partner is a carrier for alpha or beta thalassemia or a hemoglobin variant
Partner not available
Low risk of clinically important fetal hemoglobinopathy
Routine prental care
Counseling and offer prenatal diagnosis§


Screen all pregnant patients at first prenatal visit*¶Δ
Screening test reactive
Is the confirmatory test reactive?
Yes
No
Serology consistent with syphilis◇
Results most likely consistent with early infection or a false-positive screening test.
What kind of test was used as the initial screening test?¶Δ
Nontreponemal
Treponemal
Is the patient at high risk for syphilis? Risk factors include:
Commercial sex work
Exchanging sex for drugs
Having condomless sex with anonymous/>1 partner
Being diagnosed with an STI during pregnancy
Perform second treponemal test that targets different antigensΔ
Yes
No
Repeat confirmatory treponemal test in 2 to 4 weeksΔ
Initial nontreponemal test likely a false-positive§
Reactive treponemal test
Nonreactive treponemal test
Serology consistent with syphilis◇
Rescreen at 28 to 32 weeks¥
If no evidence of syphilis, screen again at delivery‡
Reactive treponemal test
Nonreactive treponemal test
Serology consistent with syphilis◇
Syphilis unlikely; initial treponemal test probably a false-positive
Is the patient at high risk for syphilis? Risk factors include:
Commercial sex work
Exchanging sex for drugs
Having condomless sex with anonymous/>1 partner
Being diagnosed with an STI during pregnancy
Yes
No
Rescreen at 28 to 32 weeks¥
If no evidence of syphilis, screen again at delivery‡

Documento de origen: Prenatal care_ Initial assessment - UpToDate.pdf

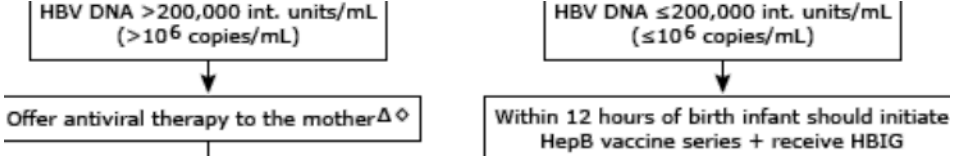


Imagen 66/66: Prenatal_care__Initial_assessment_-_UpToDate.pdf-0066-03.png